MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE COSTA RICA

Boletín Epidemiológico N° 38 de 2026

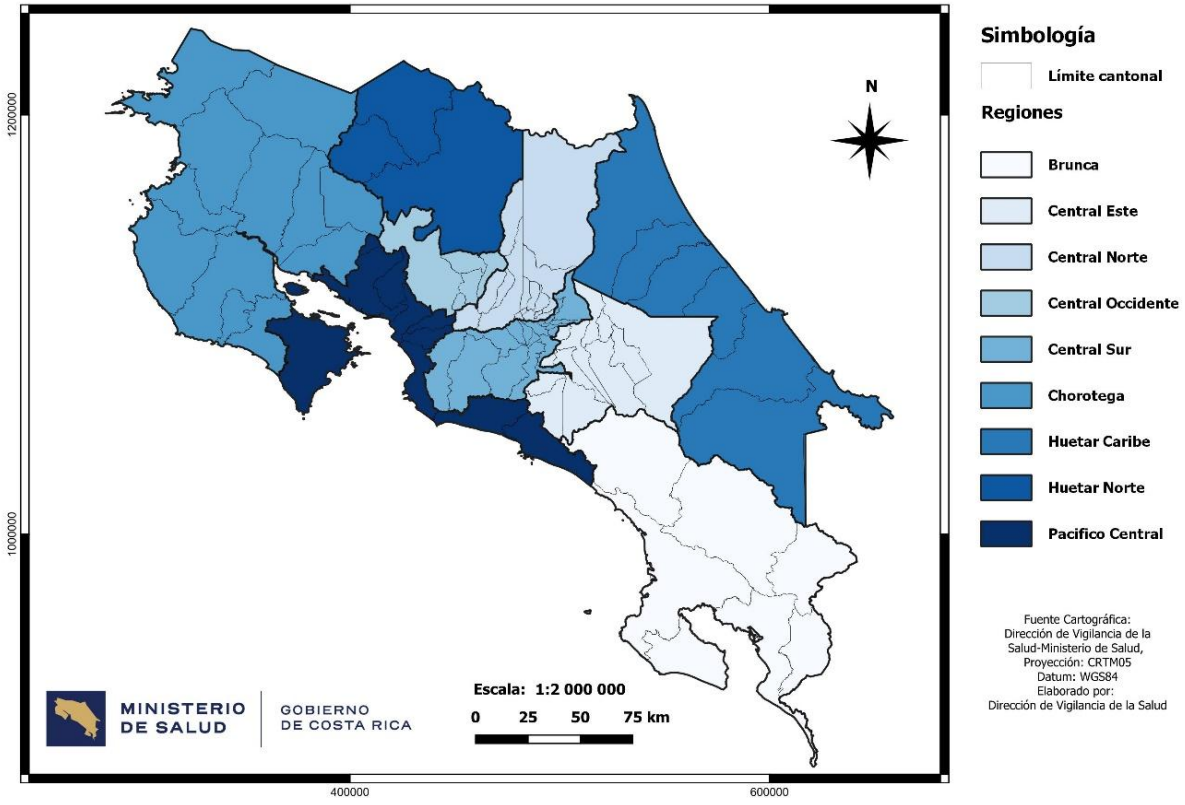
Dirección de Vigilancia de la Salud
Ministerio de Salud

16 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Situación de la malaria en Costa Rica 7
Acciones de control vectorial realizadas en el país 15
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI neumonía y Covid-19 16
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 13 de octubre 2026. 34
Infecciones de transmisión sexual 43
Miasis por gusano barrenador en humanos 53

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Dengue

A la semana epidemiológica 39 del año 2026 se notifican **5426 casos acumulados** de dengue de estos, **86 casos** como dengue con signos de alarma.
La Gerencia Médica de la CCSS a través del Área de Estadística en Salud según los datos recopilados mediante EDUS informa que al 12 de octubre se reportan 3 personas hospitalizadas con diagnóstico de dengue: 1 en el Hospital Enrique Baltodano, 1 en el Hospital San Carlos y 1 en el Hospital San Rafael de Alajuela.
La región Central Norte presenta el mayor número de casos notificados 1689 y la tasa más alta la presenta la región Pacífico Central con 378,7/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 39 2026 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Norte	1689	161,3
Pacifico Central	1219	378,7
Chorotega	725	152,8
Central Sur	538	35,5
Huetar Caribe	494	107,9
Huetar Norte	267	98,3
Central Occidente	224	99,8
Brunca	201	56,9
Central Este	69	12,5
Total	5426	104,0

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2026

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
Alajuela	2458	227,0	1299	240,4	1159	213,7
Puntarenas	812	159,6	387	153,7	425	165,3
Guanacaste	683	163,8	355	171,6	328	156,0
San José	553	33,2	279	33,0	274	33,4
Limón	494	107,9	235	105,0	259	110,7
Heredia	356	64,7	189	68,3	167	61,0
Cartago	70	13,1	33	12,3	37	14,0
Total	**5426**	**104,0**	**2777**	**106,3**	**2649**	**101,7**

Fuente: Base VE 01, Dirección de Vigilancia de la Salud.

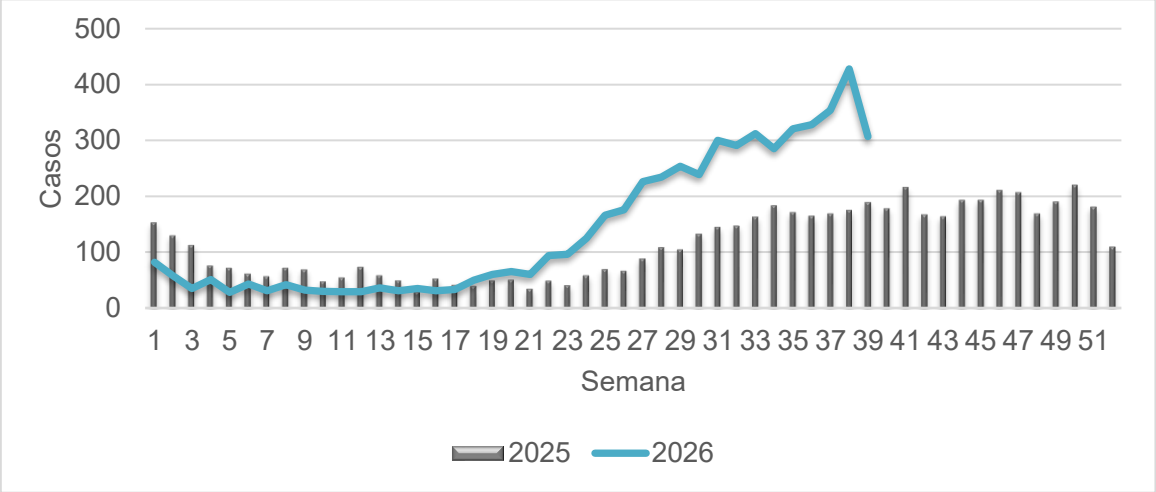
Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 39 son: Grecia 652 casos, Alajuela 577 casos, Orotina 540 casos, Puntarenas 328 casos y La Cruz 216 casos.

Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios de dengue por casos notificados a la semana epidemiológica 39, 2026.

Cantón	Casos	Tasa
203: Grecia	652	801,1
201: Alajuela	577	174,7
209: Orotina	540	2123,3
601: Puntarenas	328	225,3
510: La Cruz	216	761,6
101: San José	172	48,6
401: Heredia	159	107,9
210: San Carlos	151	70,7
702: Pococí	151	96,0
701: Limón	134	146,0

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

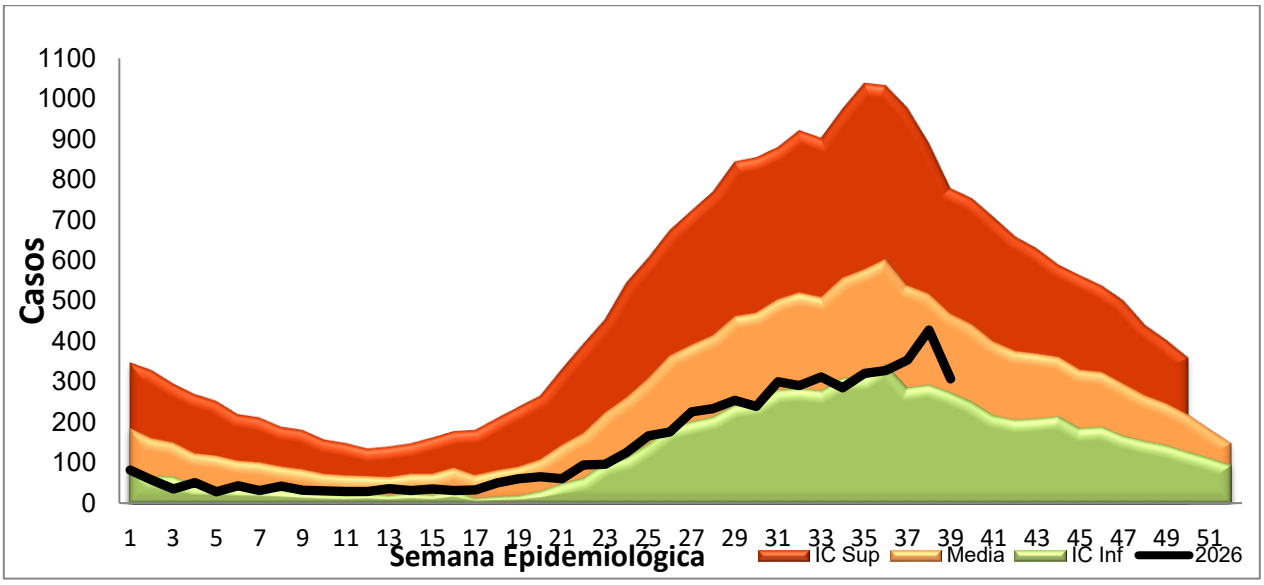
Gráfico 1.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 39, 2025-2026.



Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

Para la semana epidemiológica 39 del año 2025 se reportaron 3620 casos. En comparación con ese período, para el año 2026 se observa un incremento del 33,3% en el número de casos notificados.

Gráfico 2.
Costa Rica: canal endémico de dengue a la semana epidemiológica 39, 2026.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Chikungunya

A la semana epidemiológica 39 se notifica un total de **805 casos** de chikungunya, **638 casos confirmados** por prueba de PCR y **167 casos probables** en estudio.

Tabla 4.
Costa Rica: Casos de chikungunya por región notificados y confirmados a la semana epidemiológica 39, 2026

Región	Total	Confirmados	Probables
Chorotega	492	394	98
Central Norte	123	93	30
Central Sur	102	80	22
Pacifico Central	42	37	5
Huetar Norte	26	23	3
Central Este	10	5	5
Central Occidente	7	5	2
Huetar Caribe	2	0	2
Brunca	1	1	0
Total	**805**	**638**	**167**

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

Los cantones con mayor reporte de casos son:

- La Cruz 327 casos
- Alajuela 89 casos
- Carrillo 81 casos
- San José 59 casos
- Santa Cruz 49 casos

Situación de la malaria en Costa Rica

Actualización a la semana epidemiológica 39 del 2026

A la semana epidemiológica (SE) 39 de 2026, Costa Rica acumula **91** casos de malaria: 34 corresponden a transmisión local (19 autóctonos y 15 introducidos), 49 son importados (incluidas 9 recaídas de casos importados) y 8 casos permanece en investigación epidemiológica.

La transmisión se concentra principalmente en el foco de foco Crucitas–Llano Verde, asociado a la actividad minera y a la movilidad poblacional transfronteriza con Nicaragua. La persistencia de casos introducidos mantiene el riesgo de reintroducción y exige sostener la vigilancia intensificada, el diagnóstico oportuno y la respuesta focalizada.

Tabla 1.
Cifras clave de la situación epidemiológica de la malaria. Costa Rica, semana epidemiológica 39, 2026.

Cifras clave	SE 39-2026	Interpretación epidemiológica
Casos totales de malaria	91	Incluye casos autóctonos, introducidos, importados, recaídas y casos en investigación.
Transmisión local	34 casos	19 casos autóctonos y 15 introducidos.
Casos importados	49	Principalmente asociados a antecedentes de exposición en Nicaragua.
Casos en investigación	8	Clasificación pendiente al cierre de la SE.
Principal foco de transmisión	Crucitas–Llano Verde	Concentra 66 casos del total a nivel nacional (72.5%)

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Transmisión local

Costa Rica registra 34 casos de transmisión local en la SE 39 de 2026, distribuidos en 19 autóctonos y 15 introducidos. El 88 % se concentra en el foco de foco Crucitas–Llano Verde, en el distrito de Cutris, Región Huetar Norte, en un contexto de actividad minera y movilidad transfronteriza con Nicaragua. Los casos restantes se distribuyen entre los focos de Los Chiles, Matina y Ticarí.

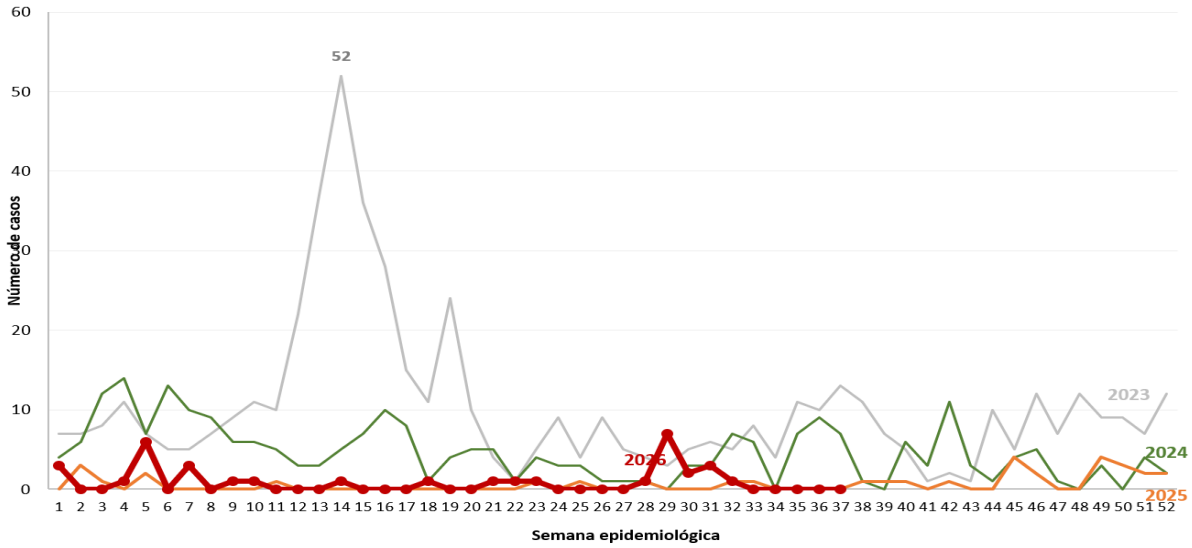
Tabla 2.
Distribución de los casos de transmisión local según clasificación epidemiológica y especie. Costa Rica, SE 39, 2026.

Clasificación	*P. vivax*	*P. falciparum*	Total
Autóctonos	18	1	19
Introducidos	14	1	15
Total	**32**	**2**	**34**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Plasmodium vivax es la especie predominante en la transmisión local (94 %); *P. falciparum* aporta apenas 2 casos (6%): uno autóctono en Matina y uno introducido en foco Crucitas–Llano Verde, lo que confirma que la circulación de esta especie, aunque marginal, no ha desaparecido.

Figura 1.
Casos de malaria por transmisión local según semana epidemiológica, Costa Rica 2023-2026*



*2026: Datos hasta la semana epidemiológica 39
Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

A la semana epidemiológica 39 de 2026 se registran 34 casos de malaria, cifra superior a los 14 casos registrados en el mismo período de 2025. No obstante, el número de casos continúa siendo considerablemente inferior al observado en 2023 y 2024, cuando se notificaron 446 y 200 casos, respectivamente.

Casos importados

Los casos importados continúan siendo la principal fuente de introducción del parásito al país. A la semana epidemiológica (SE) 39 de 2026 se registran 49 casos importados (Tabla 3), predominantemente asociados a *P. vivax* y con antecedente de exposición mayoritario en Nicaragua, lo que confirma la influencia de la movilidad poblacional transfronteriza, específicamente por la epidemiología de la malaria en Costa Rica.

Tabla 3.
Distribución de los casos importados según clasificación epidemiológica y especie. Costa Rica, SE 39, 2026.

Especie parasitaria	*Casos*	Porcentaje (%)
P. vivax	43	88
P. falciparum	5	10
Infección mixta (*P. vivax/ P. falciparum)*	1	2
Total	49	100

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

El 98 % de los casos importados presenta antecedente de exposición en Nicaragua, lo que confirma la influencia de la movilidad poblacional transfronteriza sobre la epidemiología de la malaria en el país. Sin embargo, este patrón no debe atribuirse únicamente a la migración laboral general: una parte importante de estos casos está vinculada a la actividad minera irregular en zonas fronterizas, reconocida como un factor de riesgo específico para la transmisión de malaria en la región. La mayor parte de estos casos se detecta en la Región Huetar Norte, lo que refuerza la necesidad de mantener la detección temprana, la investigación epidemiológica y la respuesta oportuna para prevenir la reintroducción de la transmisión

Distribución de casos
La distribución de los 91 casos de malaria muestra una marcada concentración en la Región Huetar Norte, que acumula 72 casos, incluida la totalidad de los introducidos y la mayor parte de autóctonos e importados. Las demás regiones registran casos esporádicos, predominantemente importados.

Tabla 4.
Distribución de casos por clasificación epidemiológica, especie y región del Ministerio de Salud, SE39-2026

Región de salud	Autóctono		Importado			Introducido		En estudio	Total
	P. f	*P. v*	Mixta (*P. v/P. f*)	*P. f*	*P. v*	*P. f*	*P. v*	*P. v*	
Central Norte	0	1	0	0	1	0	0	0	**2**
Central Occidente	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Central Sur	0	0	0	0	5	0	0	0	**5**
Chorotega	0	0	0	0	1	0	0	3	**4**
Huetar Caribe	1	0	0	0	4	0	0	0	**5**
Huetar Norte	0	17	1	5	29	1	14	5	**72**
Pacífico Central	0	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Total	**1**	**18**	**1**	**5**	**43**	**1**	**14**	**8**	**91**

P.f: *Plasmodium falciparum* P.v: *Plasmodium vivax*
Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Vigilancia Nacional

A la semana epidemiológica actual, el país reporta un total de **149 185 pruebas de diagnóstico de malaria**, resultado del esfuerzo interinstitucional para la detección oportuna de casos.

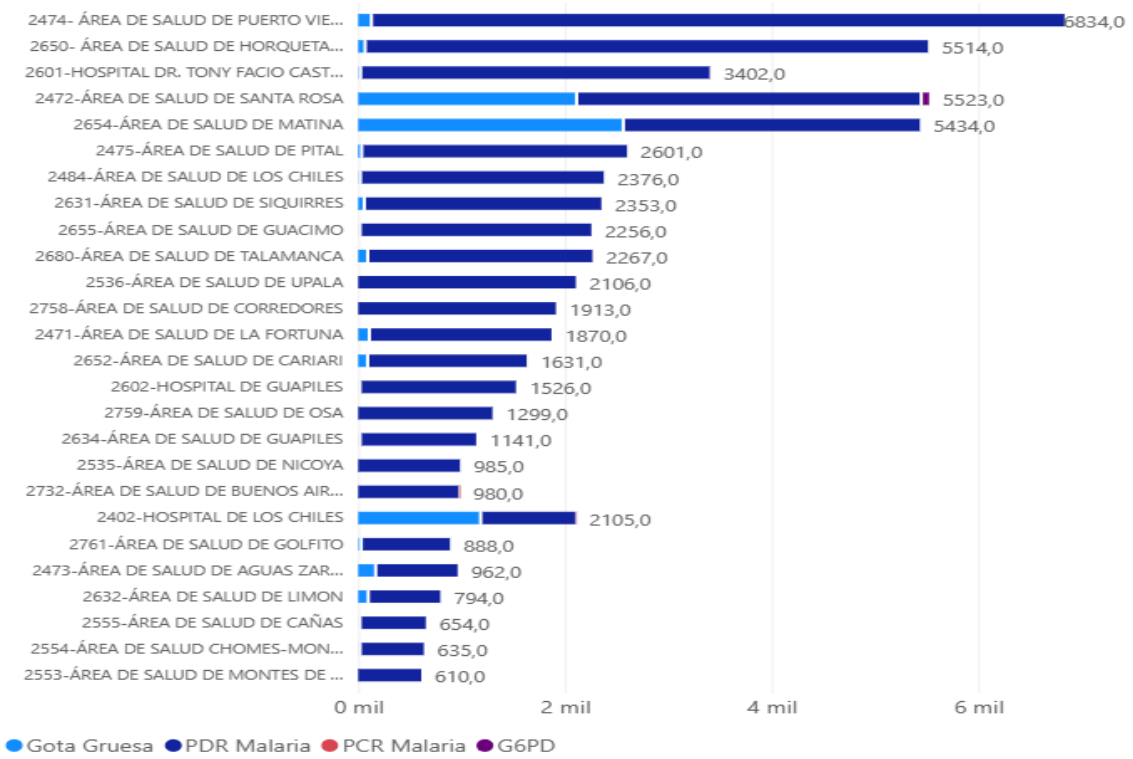
El **Ministerio de Salud registra 80 231 pruebas realizadas**, distribuidas en las diferentes Áreas Rectoras que presentan riesgo de introducción o reintroducción de la malaria. Estas corresponden principalmente a actividades de búsqueda reactiva y búsqueda proactiva, en el marco de las acciones de vigilancia intensificada, así mismo **1 404 pruebas han sido realizadas por colaboradores voluntarios**, referirse a la figura 2.

Por su parte, la **Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha realizado un total de 68 954 pruebas** en el contexto de búsqueda pasiva, distribuidas de la siguiente manera:

- 61 754 pruebas rápidas de diagnóstico (PDR),
- 6 947 exámenes de gota gruesa,
- 253 prueba de Detección de la Cadena de Polimerasa (PCR) para malaria

Este abordaje articulado fortalece la capacidad de detección temprana, confirmación diagnóstica y respuesta oportuna ante casos importados o autóctonos, en el contexto de la estrategia nacional de eliminación de la malaria.

Figura 2.
Distribución de pruebas de gota gruesa, PDR y PCR para malaria en los 20 centros de salud de la CCSS con mayor producción, Costa Rica 2026.

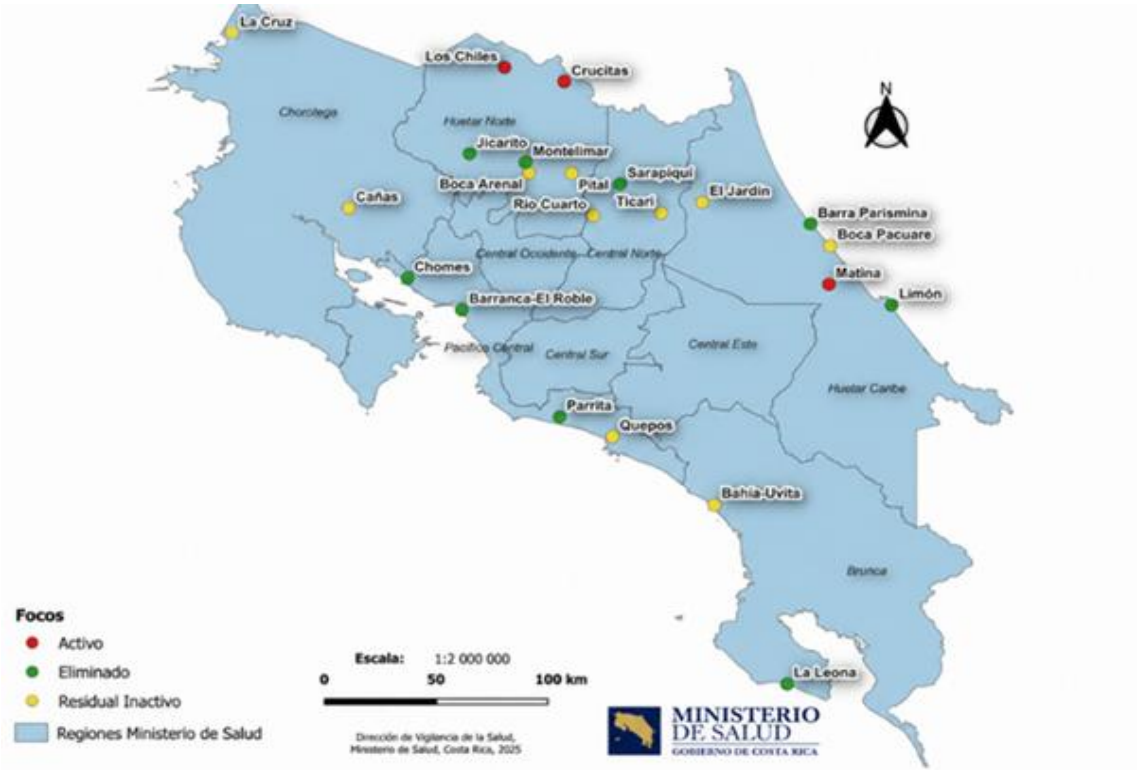


Fuente: Datos consolidados de producción de la Caja Costarricense del Seguro Socia

Inventario de focos

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 3 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 9 focos eliminados.

Figura 4.
Distribución geográfica de focos de malaria según estatus epidemiológico. Costa Rica, agosto 2026.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 5.
Listado de focos de malaria por provincia, cantón y estado epidemiológico del foco. Costa Rica, 2026

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Montelimar	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Eliminado
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Residual inactivo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Residual inactivo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Residual inactivo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Eliminado
Puntarenas	Golfito	La Leona	Eliminado
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 38

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la semana epidemiológica 38 del 2026, por el personal de Control de Vectores del país.

Tabla 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la semana epidemiológica 38

	Total
Viviendas visitadas	**10 584**
Viviendas positivas	**858**
Depósitos tratados	**47 359**
Depósitos eliminados	**86 780**
Criaderos	**134 139**
Depósitos positivos	**1 881**
Viviendas fumigadas	**20 536**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Tabla 2
Costa Rica: Acciones acumuladas de control vectorial de la semana epidemiológica 1 a la 38

	Total
Viviendas visitadas	**474 327**
Viviendas positivas	**22 692**
Depósitos tratados	**1 679 906**
Depósitos eliminados	**1 298 134**
Criaderos	**2 978 040**
Depósitos positivos	**53 012**
Viviendas fumigadas	**721 558**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI neumonía y Covid-19

Resumen epidemiológico

Los eventos de notificación general disponibles alcanzan la SE39. En esa semana se registran preliminarmente 23 571 casos de IRAS, 532 de ETI, 45 de IRAG y 51 de neumonía. Los acumulados de 2026 alcanzan 1 054 359 casos de IRAS, 11 292 de ETI, 7 196 de IRAG y 5 943 de neumonía. Las cifras de la última semana disponible pueden aumentar por rezago de notificación y no se interpretan de manera aislada como aumento o disminución frente a la semana anterior.

El componente semanal del Hospital Nacional de Niños (HNN) alcanza la SE39; la situación operativa diaria dispone de corte al 13 de octubre de 2026. En laboratorio respiratorio, con corte en la SE40, se analizaron 1 384 solicitudes válidas y 673 presentaron al menos un virus detectado, para una positividad global de 48,6 %.

Los casos nacionales de COVID-19 tienen último dato validado en la SE40, con 91 casos. La CCSS reportó al 13 de octubre 13 pacientes positivos hospitalizados en salón y 2 en UCI. Para los fallecidos, el último dato disponible corresponde a la SE40, con 3 fallecidos con COVID-19 según semana epidemiológica de egreso, todos en hospitalización y ninguno en urgencias; este dato corresponde al registro institucional de la CCSS y no a la mortalidad nacional total.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos notificados en la última semana epidemiológica disponible y acumulados de IRAS, ETI, IRAG y neumonía, 2026.

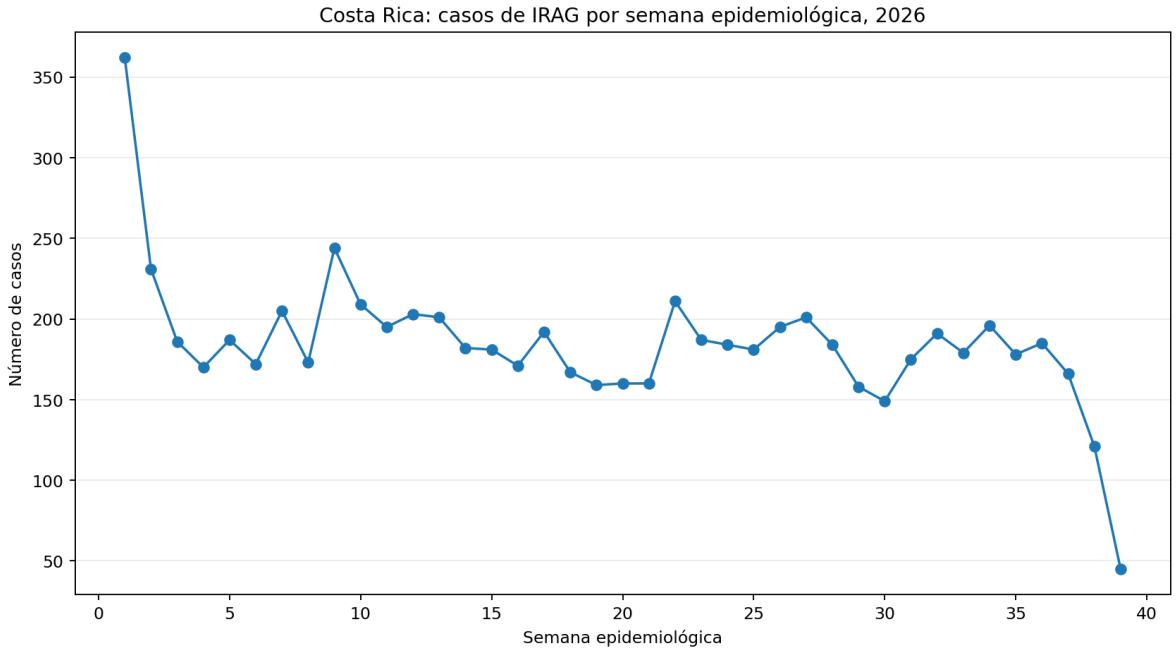
Evento	Última SE	Casos en la SE	Acumulado 2026
IRAS	SE39	23 571	1 054 359
ETI	SE39	532	11 292
IRAG	SE39	45	7 196
Neumonía	SE39	51	5 943

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)

Según los registros de la boleta VE-01, a la SE39 se acumulan 7 196 casos de IRAG; en esa semana se notificaron preliminarmente 45 casos. La mayor carga acumulada se concentra en las personas de 75 años y más (1 768 casos), seguidas por los niños de 1 a 4 años (1 249) y los menores de 1 año (1 239), lo que evidencia que los extremos de la vida continúan concentrando una proporción importante de los casos notificados. El dato de la SE39 es preliminar y puede aumentar por rezago de notificación.

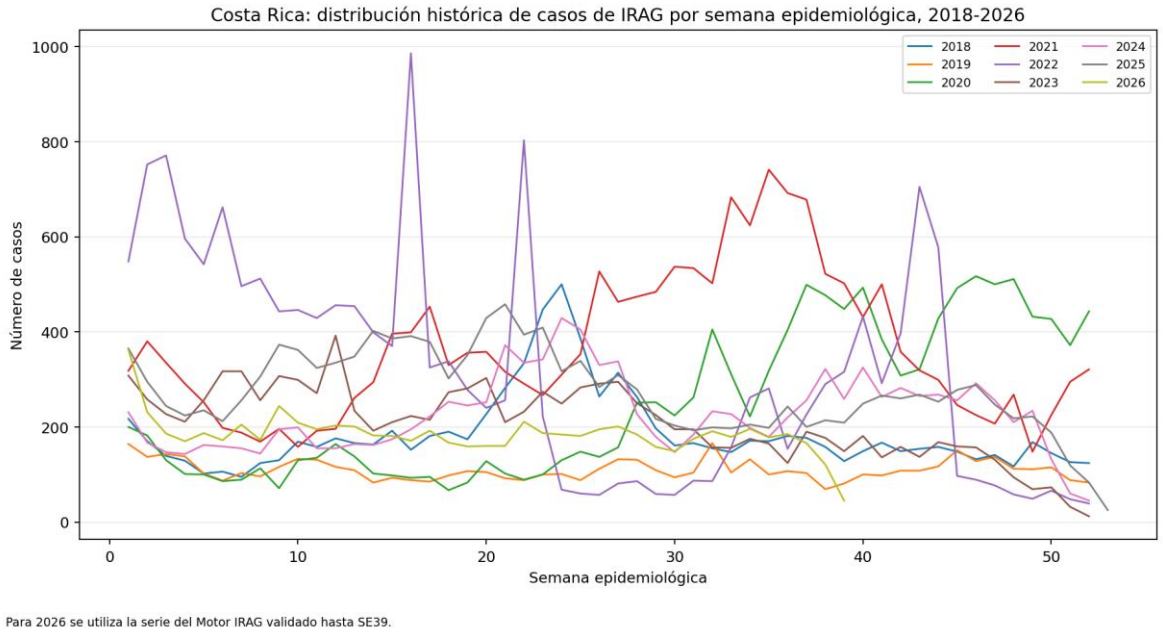
Gráfico 1.
Costa Rica: Casos de IRAG por semana epidemiológica, 2026.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud. Métrica: IRAG_LEGADO_NOTIFICACIONES.

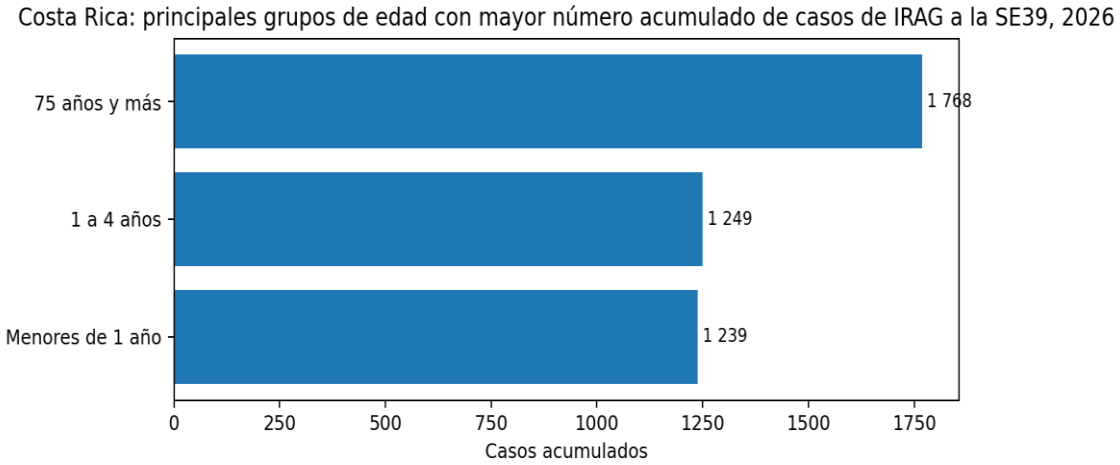
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 2.
Costa Rica: Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, 2018-2026.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 3.
Costa Rica: Principales grupos de edad con mayor número acumulado de casos de IRAG a la SE39, 2026.

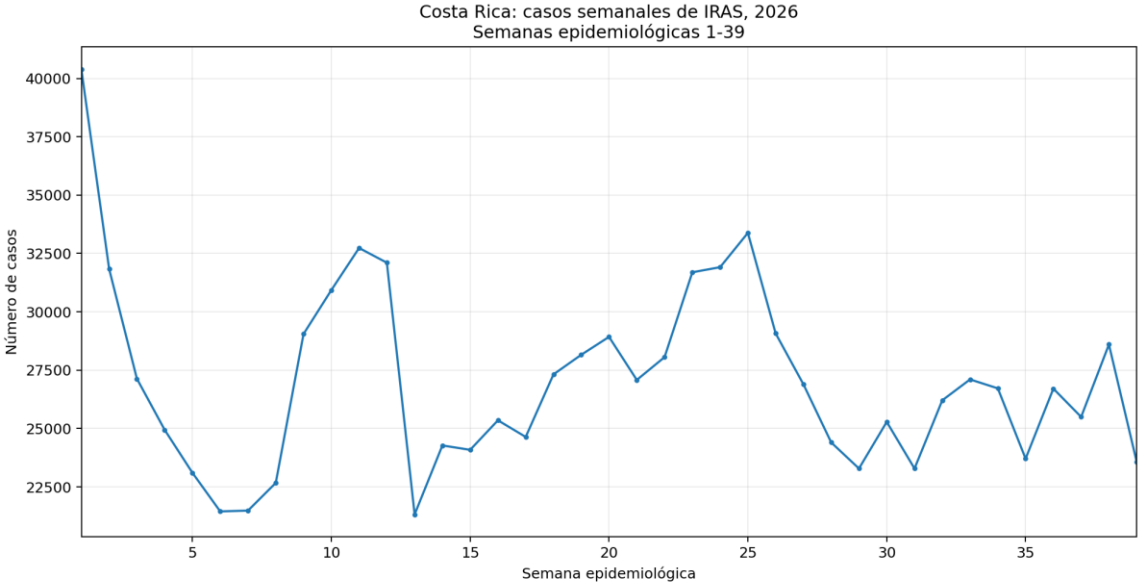


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Infecciones respiratorias agudas (IRAS)

Según los registros de la boleta VE-02, a la SE39 se acumulan 1 054 359 casos de IRAS; en esa semana se registraron preliminarmente 23 571 casos. Los mayores acumulados corresponden a los niños de 1 a 4 años (118 576) y de 5 a 9 años (109 408), lo que evidencia una mayor carga acumulada en población infantil. El dato de la SE39 es preliminar y puede aumentar por rezago de notificación.

Gráfico 4.
Costa Rica: Casos semanales de IRAS, 2026.

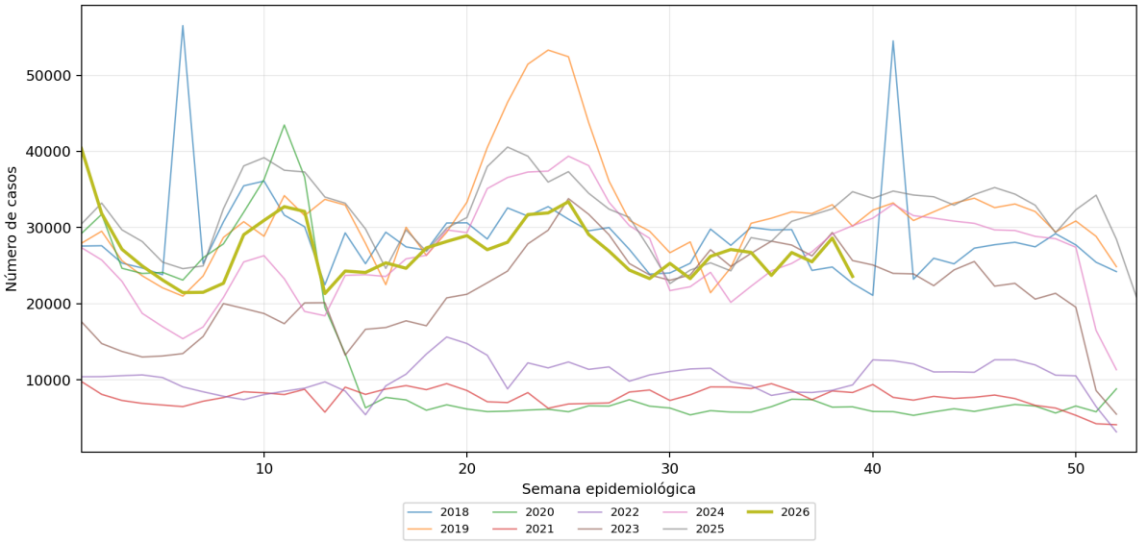


Nota: corte oficial a la semana epidemiológica 39; los registros posteriores al corte no se incluyen.

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS. Procesamiento: Ministerio de Salud, 2026.

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

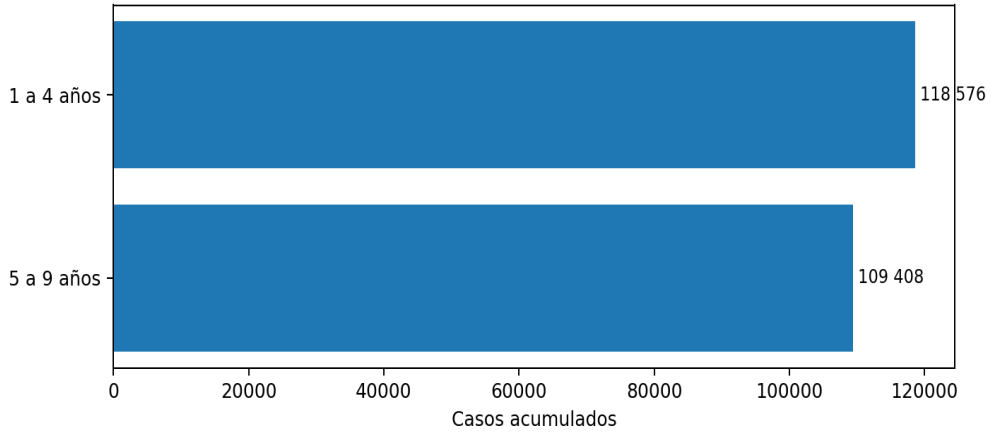
Gráfico 5.
Costa Rica: Distribución histórica semanal de IRAS, 2018-2026.



Nota: para 2026, la serie se presenta hasta la semana epidemiológica 39.

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 6.
Costa Rica: Principales grupos de edad con mayor número acumulado de casos de IRAS a la SE39, 2026.

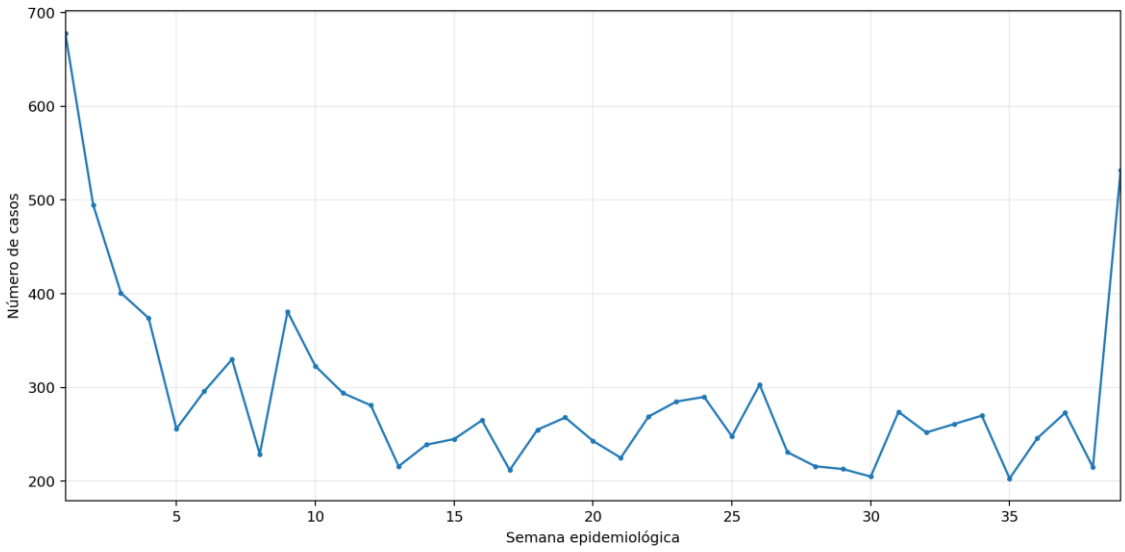


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Enfermedad tipo influenza (ETI)

Según los registros de la boleta VE-02, a la SE39 se acumulan 11 292 casos de ETI. En esa semana se registraron 532 casos, frente a 215 en la SE38, lo que representa un incremento de 147,4 %. Los mayores acumulados corresponden a los grupos de 25 a 29 años (1 018 casos) y 30 a 34 años (1 017), lo que evidencia una mayor carga acumulada en adultos jóvenes. El dato de la SE39 debe interpretarse con cautela por corresponder a la semana más reciente y analizarse conjuntamente con la circulación de virus respiratorios identificada por laboratorio.

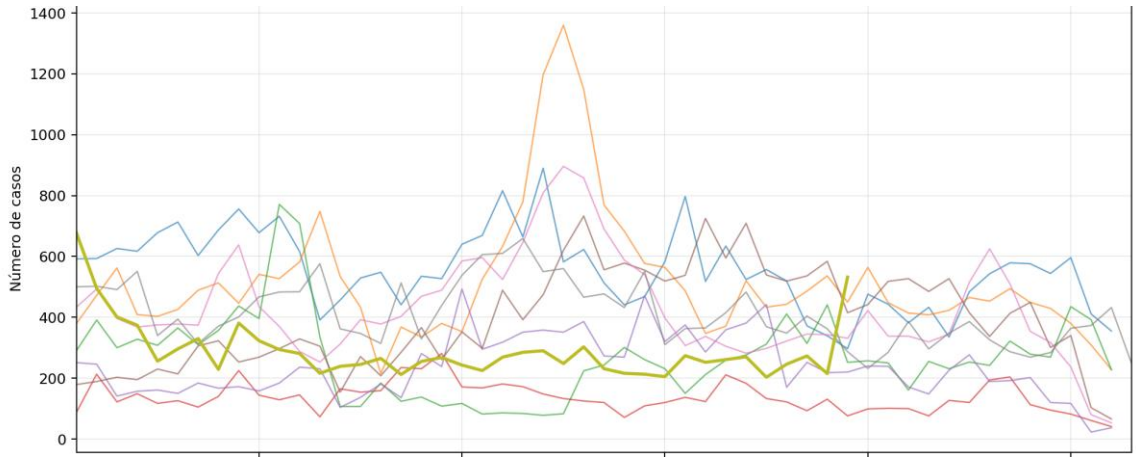
Gráfico 7.
Costa Rica: Casos semanales de ETI, 2026.



Nota: corte oficial a la semana epidemiológica 39; los registros posteriores al corte no se incluyen.

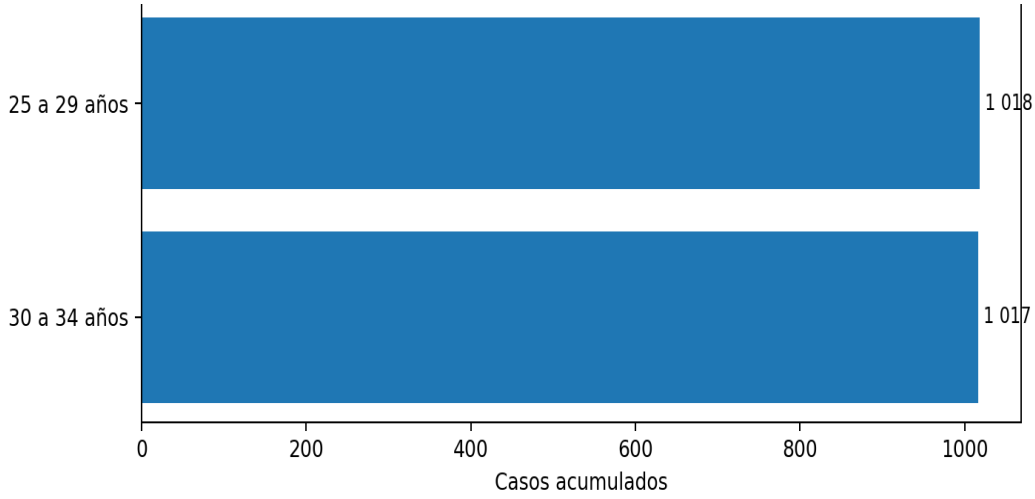
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 8.
Costa Rica: Distribución histórica semanal de ETI, 2018-2026.



Nota: para 2026, la serie se presenta hasta la semana epidemiológica 39.
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 9.
Costa Rica: Principales grupos de edad con mayor número acumulado de casos de ETI a la SE39, 2026.

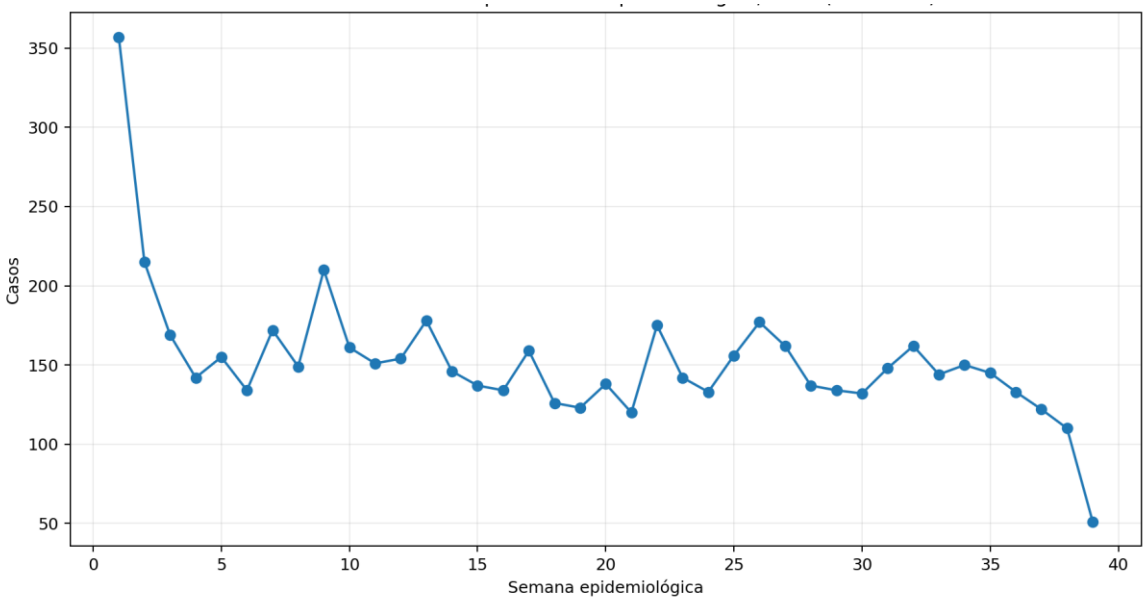


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Neumonía

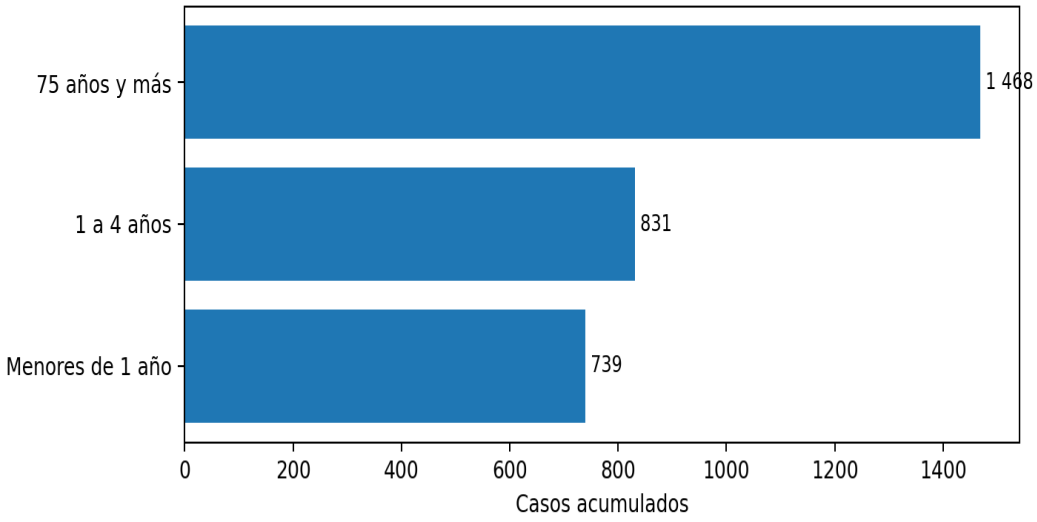
A la SE39 se registran 5 943 casos acumulados de neumonía; en esa semana se notificaron preliminarmente 51 casos. La mayor carga acumulada corresponde a las personas de 75 años y más (1 468 casos), seguidas por los niños de 1 a 4 años (831) y los menores de 1 año (739), evidenciando nuevamente una concentración importante en los extremos de la vida. La distribución acumulada por sexo es similar, con 2 989 casos en mujeres y 2 954 en hombres. Los mayores acumulados regionales corresponden a la Región Central Sur (1 932), Central Este (1 144) y Central Norte (897). El dato de la SE39 es preliminar y puede aumentar por rezago de notificación.

Gráfico 10.
Costa Rica: Neumonía notificada por semana epidemiológica, 2026.



Nota: para 2026, la serie se presenta hasta la semana epidemiológica 39.
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 11.
Costa Rica: Principales grupos de edad con mayor número acumulado de casos de neumonía a la SE39, 2026.

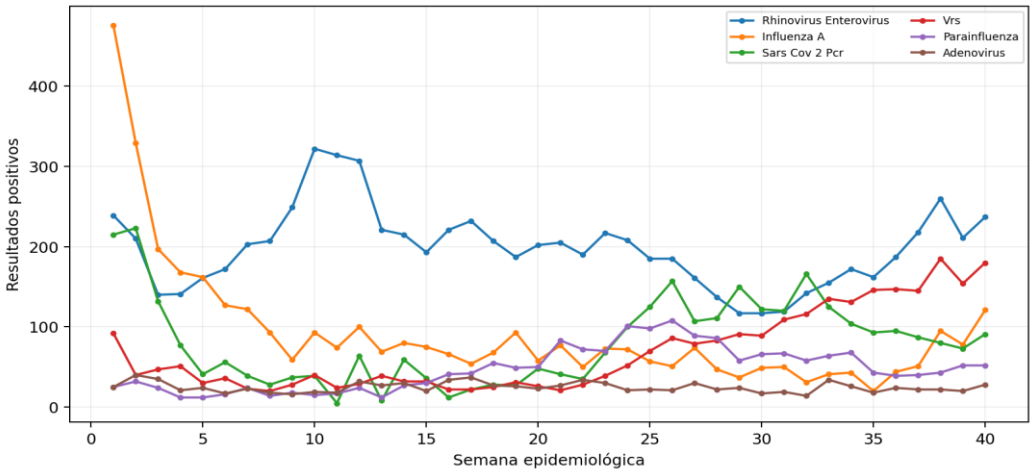


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Vigilancia de laboratorio de virus respiratorios

Con corte en la SE40 se analizaron 1 384 solicitudes válidas, de las cuales 673 presentaron al menos un virus detectado, para una positividad global de 48,6 %. Los agentes con mayor número de detecciones fueron Rinovirus/Enterovirus (237) y virus respiratorio sincitial (VRS) (180). La positividad global se calcula por solicitud, mientras que las detecciones por agente corresponden a una métrica diferente y no deben sumarse ni interpretarse como solicitudes positivas únicas. La interpretación de este componente se realiza conjuntamente con la notificación sindrómica, la vigilancia hospitalaria y la situación pediátrica.

Gráfico 12.
Costa Rica: Circulación semanal de virus respiratorios, 2026.



Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), laboratorio de virus respiratorios, 2026.

Situación pediátrica - Hospital Nacional de Niños

La situación pediátrica integra dos componentes complementarios: el reporte operativo diario y la vigilancia epidemiológica semanal del HNN. El reporte operativo diario dispone de corte al 13 de octubre de 2026, mientras que la vigilancia epidemiológica semanal mantiene como último corte disponible la SE39; ambos se presentan por separado para conservar la temporalidad propia de cada fuente.

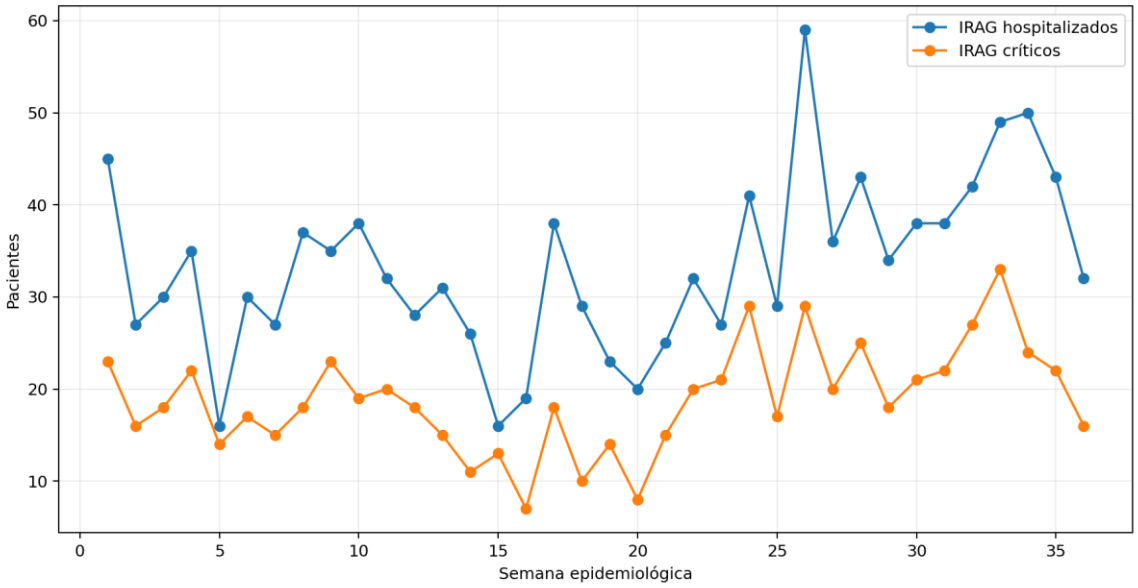
Cuadro 2.
Costa Rica: Situación operativa respiratoria, Hospital Nacional de Niños, 13 de octubre de 2026.

Indicador	Dato
Pacientes respiratorios hospitalizados	93
Ocupación respecto de dotación habitual	139 %
Ocupación respecto de dotación expandida	98 %
Pacientes respiratorios en Emergencias	16
Total de pacientes respiratorios HNN	109
Pacientes respiratorios en UCI	22
Ocupación de UCI	100 %

Fuente: Hospital Nacional de Niños, CCSS. Reporte operativo diario del 13/10/2026.

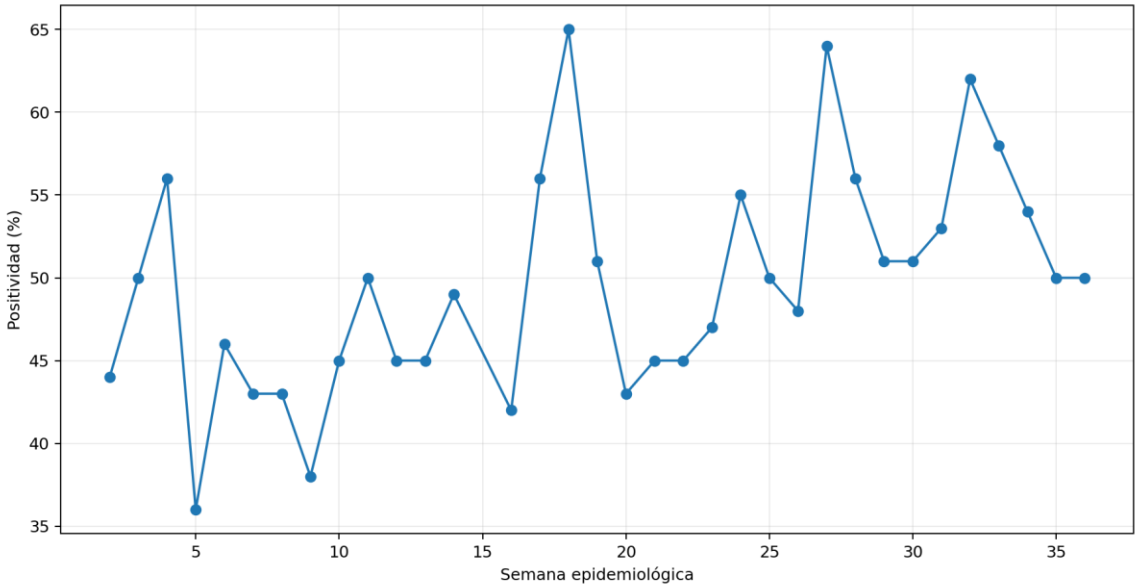
En la SE39 se registraron 48 hospitalizados por IRAG, 35 de ellos en condición crítica (72,9 %). En el componente de laboratorio se procesaron 162 muestras respiratorias, de las cuales 93 resultaron positivas (57,0 %). La mortalidad acumulada por IRAG alcanzó 14 fallecimientos al 08/10/2026. En conjunto, estos indicadores muestran una presión asistencial importante en la población pediátrica, por lo que la situación operativa diaria debe interpretarse conjuntamente con la vigilancia epidemiológica semanal.

Gráfico 13.
Costa Rica: IRAG hospitalizados y críticos por semana epidemiológica, Hospital Nacional de Niños, 2026.



Fuente: Hospital Nacional de Niños, CCSS. Vigilancia epidemiológica semanal, 2026.

Gráfico 14.
Costa Rica: Positividad de muestras respiratorias por semana de informe, Hospital Nacional de Niños, 2026.

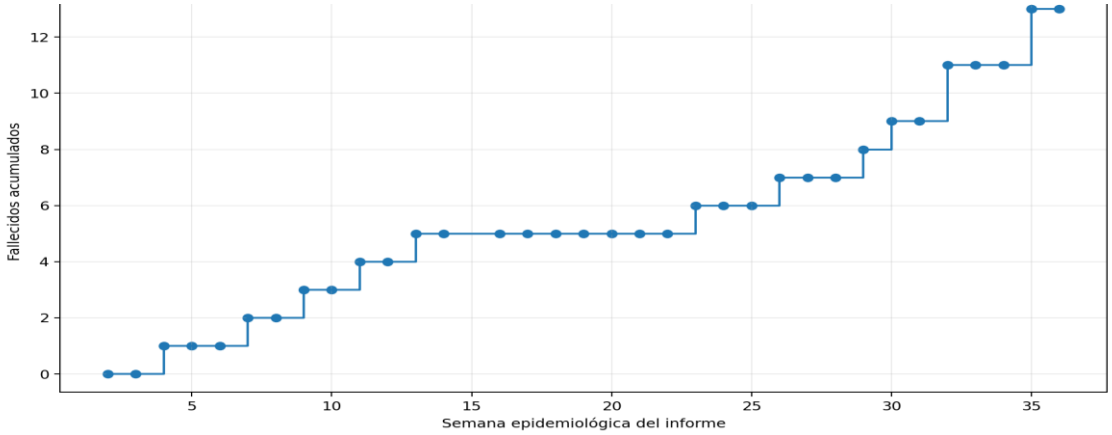


Fuente: Hospital Nacional de Niños, CCSS. Vigilancia epidemiológica semanal, 2026.

Mortalidad acumulada por IRAG - Hospital Nacional de Niños

Al 8 de octubre de 2026, el Hospital Nacional de Niños reporta 14 fallecimientos acumulados por IRAG. La serie corresponde al acumulado informado en los reportes epidemiológicos semanales y no permite asignar la semana epidemiológica de ocurrencia de cada fallecimiento. Por esta razón, el indicador debe interpretarse como evolución del acumulado reportado y no como una curva temporal de mortalidad.

Gráfico 15.
Costa Rica: Fallecimientos acumulados por IRAG según semana de informe, Hospital Nacional de Niños, 2026.

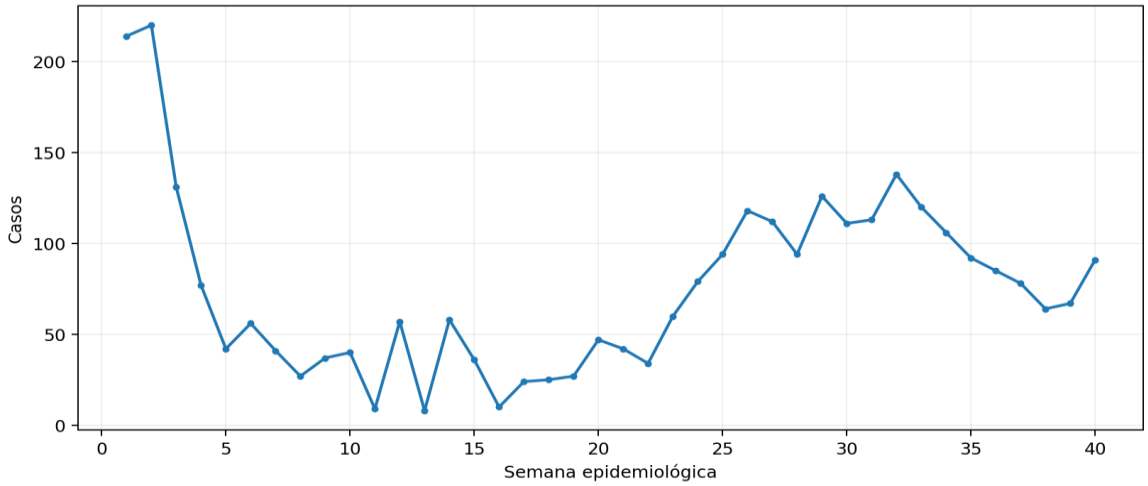


Fuente: Hospital Nacional de Niños, CCSS. Vigilancia epidemiológica semanal, SE39 de 2026.

COVID-19

Los casos nacionales de COVID-19 cuentan con último dato validado en la SE40, con 91 casos registrados. Este dato corresponde a la semana más reciente disponible y debe interpretarse en el contexto de la serie epidemiológica completa, sin utilizarse de manera aislada para inferir una tendencia.

Gráfico 16.
Costa Rica: Casos nacionales de COVID-19 por semana epidemiológica, 2026.



Fuente: Vigilancia nacional de COVID-19, sector público y privado. Ministerio de Salud, 2026.

Hospitalización y fallecidos registrados por la CCSS

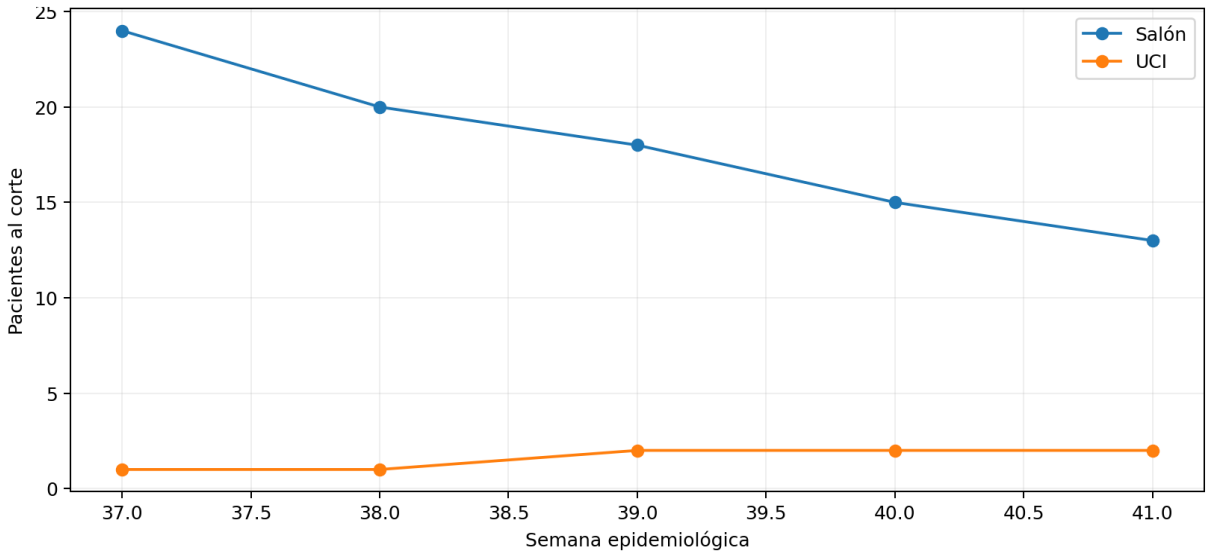
Al corte del 13 de octubre de 2026, correspondiente a la SE41, la CCSS reportó 13 pacientes positivos hospitalizados en salón y 2 pacientes en UCI. Para fallecidos no se dispone de dato en la SE41; el último dato disponible corresponde a la SE40, con 3 fallecidos con COVID-19 según semana epidemiológica de egreso, todos en hospitalización y ninguno en urgencias. Estos fallecidos corresponden al registro hospitalario institucional de la CCSS y no representan la mortalidad nacional total por COVID-19.

Cuadro 3.
Costa Rica: Pacientes positivos por COVID-19 hospitalizados al corte semanal, CCSS, 2026.

Corte	Semana	Salón	UCI
17/09/2026	SE37	24	1
26/09/2026	SE38	20	1
03/10/2026	SE39	18	2
10/10/2026	SE40	15	2
13/10/2026	SE41	13	2

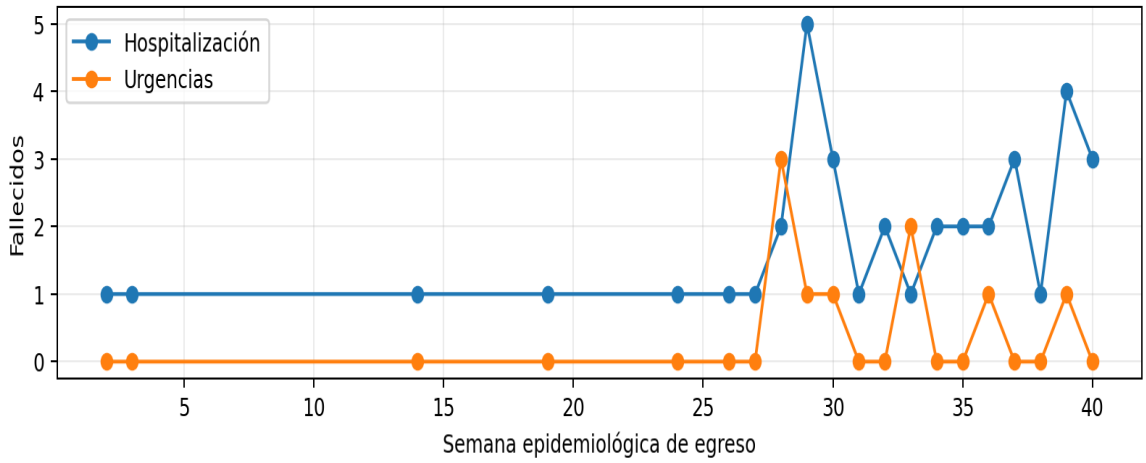
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Power BI institucional, 2026.

Gráfico 17.
Costa Rica: Pacientes positivos por COVID-19 hospitalizados en salón y UCI según fecha de corte, CCSS, 2026.



Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Power BI institucional. Corte consultado el 13/10/2026.

Gráfico 18.
Costa Rica: Fallecidos con COVID-19 según semana epidemiológica de egreso y servicio, CCSS, 2026.

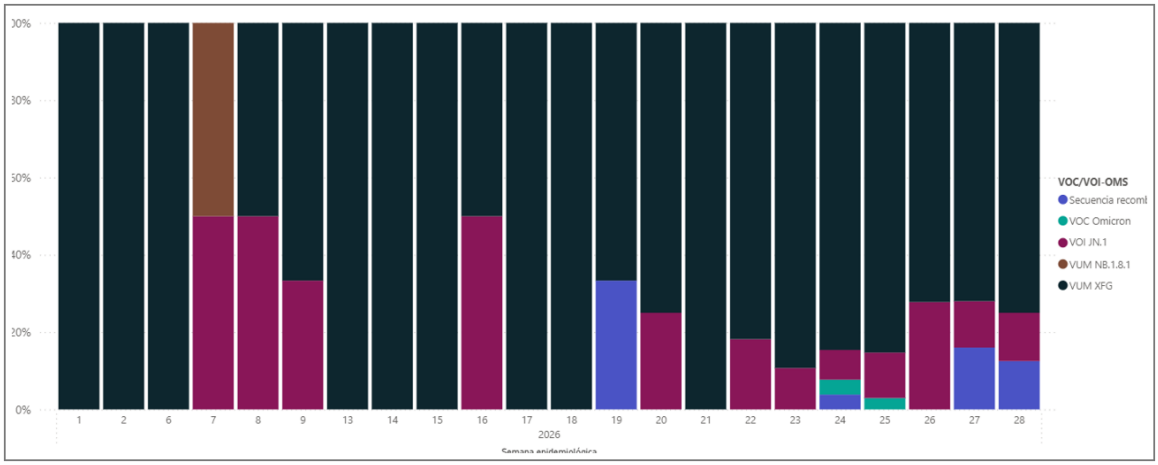


Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Power BI institucional. Último dato de fallecidos: SE40; corte consultado el 13/10/2026.

Vigilancia genómica de SARS-CoV-2

El último corte visual documentado disponible del panel de vigilancia genómica de INCIENSA alcanza la SE28 de 2026. Debido a que este componente presenta un corte anterior al resto de la vigilancia respiratoria incluida en este boletín, sus resultados se presentan como información complementaria y no deben extrapolarse para describir la circulación de linajes en semanas posteriores.

Gráfico 19.
Costa Rica: Proporción de linajes identificados según semana y año epidemiológico para VOC/VOI/VUM, 2026.



Fuente: INCIENSA, vigilancia genómica de SARS-CoV-2, 2026.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 13 de octubre 2026.

Situación epidemiológica actual de EDA

Al cierre de la SE 39 del 2026 se contabilizan 353641 casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) correspondientes a las semanas epidemiológicas (SE) de la 1 a la 39. La mayor carga del año se concentró principalmente entre las SE 14–16 y 20–21. La SE 15 continúa registrando el mayor número de casos, con 12 238, seguida de la SE 14 con 12 201 y la SE 20 con 11 773 casos. En las semanas más recientes se observa una disminución progresiva: la SE 36 se registraron 6 266, la SE 37: 6161, la SE 38: 6766 y la 39 5792casos preliminares.
Esta reducción debe interpretarse con cautela, particularmente en las SE más recientes, debido al rezago habitual en la notificación y consolidación de los registros del sistema de vigilancia. Las cifras recientes pueden encontrarse parcialmente subestimadas, dado que la consolidación de la información suele completarse entre dos y tres semanas después de la semana epidemiológica analizada.

De acuerdo con el análisis del canal endémico, durante 2026 se han presentado varias semanas con valores superiores a los esperados. Para la SE 39 se registran 5 792 casos, valor ligeramente superior al umbral de alerta estimado para esa semana (aproximadamente 5 417 casos). Este hallazgo debe interpretarse considerando el carácter preliminar de los datos y el rezago de notificación.

El comportamiento de la EDA puede estar influenciado por factores ambientales, climáticos y conductuales, entre ellos las condiciones de manipulación y conservación de los alimentos, la calidad y disponibilidad del agua, las prácticas de higiene y los patrones de movilidad e interacción de la población. Estos factores deben analizarse juntamente con la tendencia temporal, la distribución territorial y la ocurrencia de brotes.

En este contexto, se mantiene la vigilancia epidemiológica intensificada de la EDA, con seguimiento continuo de la tendencia temporal, la distribución territorial y la ocurrencia de brotes, con el propósito de identificar oportunamente cambios relevantes o concentraciones inusuales de casos o desviaciones respecto al comportamiento esperado.

Contexto climático 2026 y EDA

Las condiciones climáticas pueden influir de manera importante en el comportamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), al modificar la temperatura ambiental, los patrones de precipitación, la disponibilidad y calidad del agua y las condiciones de conservación de los alimentos.

Durante 2026, uno de los principales incrementos de EDA se concentró entre las SE 14–16, período que coincidió con condiciones de temperaturas elevadas reportadas en distintas zonas del país. Un segundo incremento se observó durante las SE 20–21, en el contexto de la transición hacia la época lluviosa, caracterizada por temperaturas aún elevadas, aumento de la humedad y cambios en los patrones de precipitación. Esta coincidencia temporal resulta epidemiológicamente relevante, aunque por sí sola no permite establecer una relación causal.

Las temperaturas elevadas pueden favorecer la proliferación y supervivencia de microorganismos en alimentos y agua, así como acelerar el deterioro de productos perecederos cuando existen condiciones inadecuadas de refrigeración, almacenamiento o manipulación. De forma paralela, las variaciones en las lluvias y en los sistemas de abastecimiento pueden afectar la disponibilidad y calidad microbiológica del agua, especialmente en comunidades con interrupciones del servicio, almacenamiento inadecuado o acceso limitado a fuentes seguras.

A estos factores ambientales se suman prácticas de higiene y manipulación de alimentos que pueden incrementar el riesgo de transmisión, entre ellas el lavado insuficiente de manos, la contaminación cruzada y las deficiencias en la preparación y conservación de los alimentos.

En conjunto, la interacción entre temperatura, precipitación, humedad, disponibilidad de agua, inocuidad de los alimentos y prácticas de higiene puede generar condiciones favorables para la transmisión de agentes causantes de EDA. Por esta razón, el monitoreo de las variables climáticas constituye un componente complementario de la vigilancia epidemiológica, al contribuir a identificar períodos de mayor riesgo y orientar oportunamente las acciones de prevención y control.

Canal endémico EDA

Entre las SE 30 y 39 se registraron 68 118 casos de EDA, con un promedio de 6 811 casos por semana. En este período se observa una disminución de los registros semanales, pasando de 7 798 casos en la SE 30 a 5 792 en la SE 39, lo que representa una reducción observada de 25,7 %.

Los datos correspondientes a las semanas epidemiológicas más recientes son preliminares y se encuentran en proceso de consolidación, por lo que la posición de la curva dentro del canal endémico puede modificarse conforme se incorporen registros adicionales.

El canal endémico permite comparar el comportamiento observado en 2026 con los límites históricos esperados para la EDA, distribuidos en zona de éxito, zona de seguridad y zona de alerta.

Durante 2026, la curva ha presentado variaciones importantes y en diferentes momentos se ha ubicado por encima de los valores esperados, con ingreso a la zona de alerta. En la SE 39 el valor observado se mantiene ligeramente por encima del umbral de alerta del canal endémico.

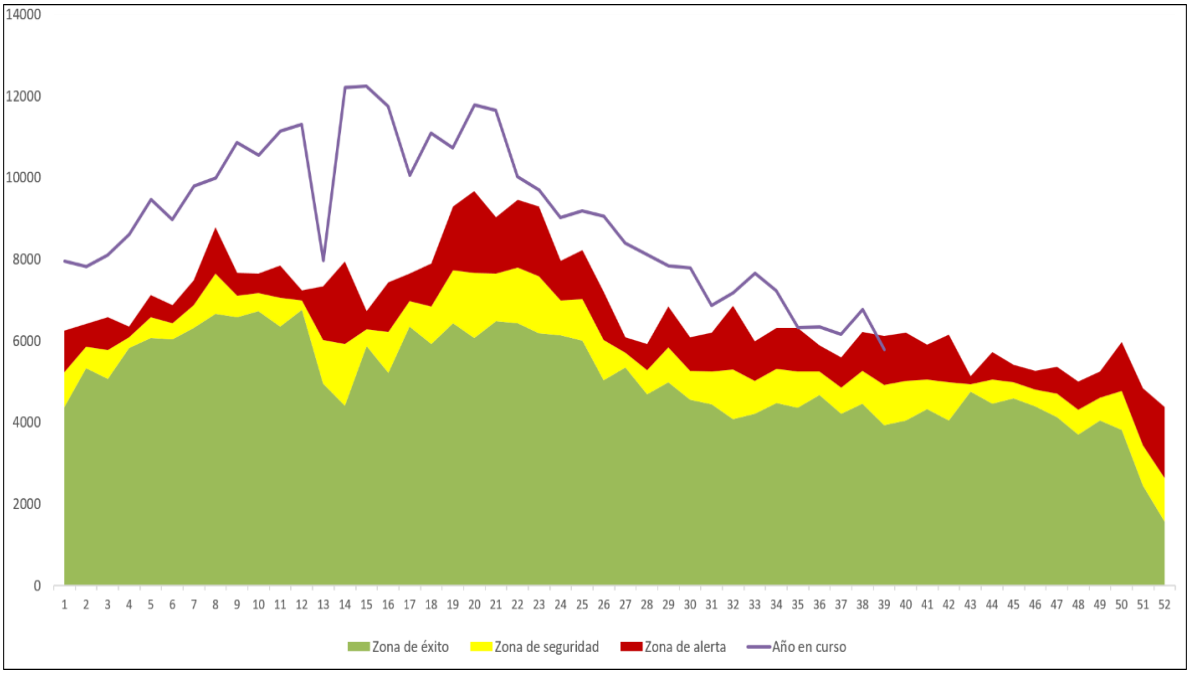
Aunque desde la SE 33 se observa un descenso progresivo de la curva, la SE 39 continúa requiriendo seguimiento por ubicarse ligeramente por encima del umbral de alerta. Debido al rezago de notificación de las semanas más recientes, es necesario esperar la consolidación de los datos antes de determinar si la reducción representa un cambio sostenido en la tendencia.

En términos generales, el canal endémico evidencia que durante 2026 se han presentado períodos de elevada actividad de EDA, alternados con semanas de

menor incidencia. La información disponible hasta la SE 39 muestra una tendencia descendente reciente, pero aún con valores que requieren vigilancia estrecha frente a los límites históricos esperados.

El análisis continuo del canal endémico permite identificar oportunamente desviaciones respecto al comportamiento histórico y orientar la vigilancia hacia períodos o territorios que requieran investigación adicional.

Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 39. Años 2018- 2026 *

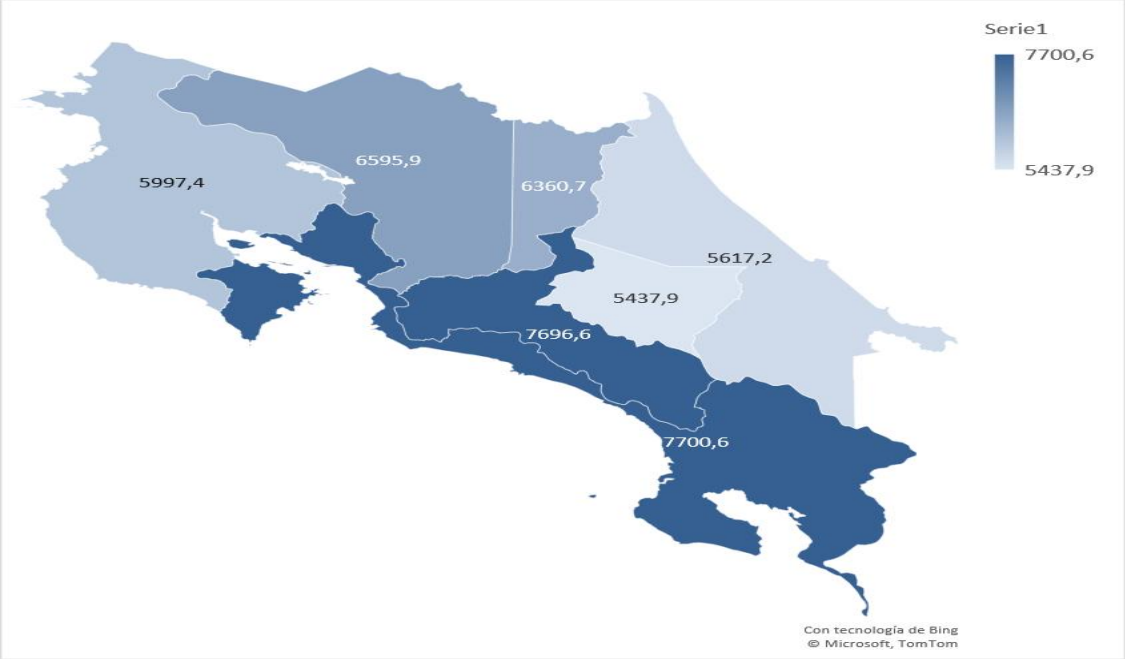


Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.
*Nota: Se excluyen del 2020 y 2021 por la pandemia COVID-19 y 2022 por hackeo de la CCSS.

Distribución territorial de la EDA

La tasa acumulada nacional de EDA hasta la SE 39 de 2026 se estima en 6778,2 casos por 100 000 habitantes. A nivel provincial, Puntarenas (7700,6) y San José (7696,6) presentan tasas superiores al promedio nacional, mientras que Alajuela (6595,9), Heredia (6369), Guanacaste (5997), Limón (5617) y Cartago (5437) se mantienen por debajo de este valor.

Figura 1
Costa Rica. Tasa de Incidencia de EDA, según provincia. SE 39, 2026



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

El análisis por región de salud evidencia una mayor concentración de la enfermedad en el Pacífico Central, con una tasa aproximada de 9828, casos por 100 000 habitantes, seguido de la Región Central Sur, con 8018,5 por 100 000 habitantes. Posteriormente se ubican la Región Central Norte (6631), Huetar Norte (6502), Chorotega (6075), Huetar Caribe (5617), Central Este (5555), Central Occidente (5276) y Brunca (4648). Este comportamiento permite identificar territorios prioritarios para el seguimiento epidemiológico y el análisis de posibles factores locales asociados.

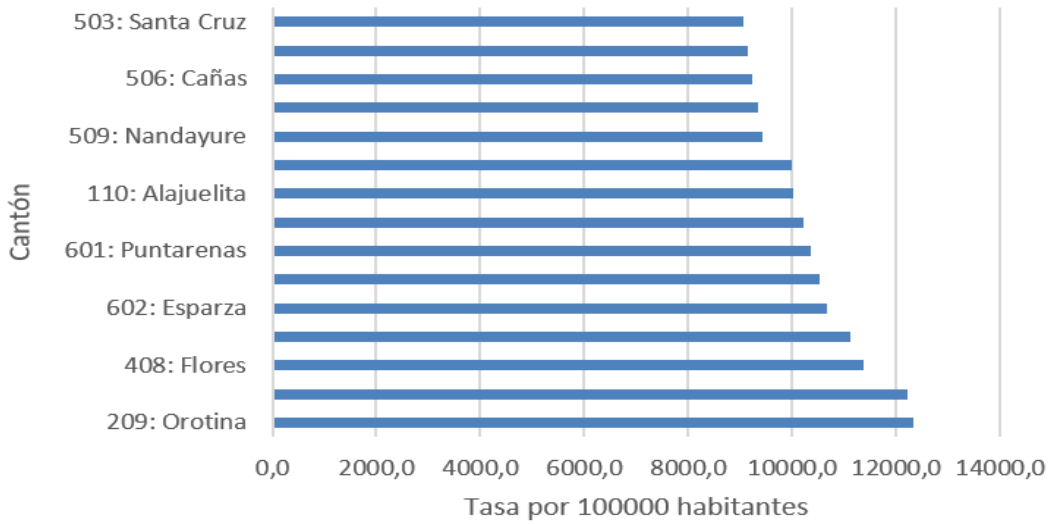
Cantones con mayor incidencia

La distribución cantonal evidencia diferencias importantes en la incidencia acumulada de EDA. Orotina presenta la tasa más alta del país, con 12 338 casos por 100 000 habitantes, seguido de Vázquez de Coronado (12208), Flores (11 386,3), Montes de Oro (11132) y Esparza (10665). Estas tasas se encuentran entre las más elevadas observadas en el período analizado.

También presentan incidencias elevadas los cantones de Mora (10538), Puntarenas (10363), Goicoechea (10218), Alajuelita (10015), San José (9999) y Asimismo, destacan Nandayure (9417), San Rafael (9357), Cañas (9243), El Guarco (9137) y Santa Cruz (9049), evidenciando la presencia de cantones con alta incidencia en distintas regiones del país.

La distribución territorial confirma que la carga de EDA no es homogénea entre los cantones. Destacan Orotina, Vázquez de Coronado, Flores, Montes de Oro, Esparza, Mora, Puntarenas, Goicochea y Alajuelita, todos con tasas superiores a 10 000 casos por 100 000 habitantes durante el período analizado. Estos resultados permiten reconocer áreas prioritarias para el seguimiento epidemiológico y el análisis de los factores asociados a la mayor incidencia observada.

Gráfico 2
Costa Rica. Cantones con mayor tasa acumulada de EDA, SE 39, 2026



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica, estos hallazgos respaldan la necesidad de priorizar el análisis de los territorios con tasas persistentemente elevadas, integrando información sobre brotes, abastecimiento y calidad del agua,

establecimientos de alimentos, condiciones ambientales, movilidad poblacional y otros determinantes locales que permitan explicar las diferencias observadas.

Distribución por grupos de edad y sexo

La distribución por edad mantiene un patrón bimodal, con las tasas más elevadas en la niñez temprana y en los adultos jóvenes. La mayor tasa se registra en el grupo de 20 a 24 años, con 11 812,7 casos por 100 000 habitantes, seguido por los grupos de 25 a 29 años (10 715,1), 1 a 4 años (10 174,8) y menores de 1 año (9 790,9).
Este comportamiento concentra la atención en dos grupos de interés epidemiológico: los menores de cinco años, por su vulnerabilidad ante las complicaciones asociadas a los cuadros gastrointestinales, y los adultos jóvenes de 20 a 29 años, quienes presentan las tasas de incidencia más elevadas del período analizado.
A partir de los 40 años se observa una disminución progresiva de las tasas, pasando de 6 451,7 casos por 100 000 habitantes en el grupo de 40 a 44 años a 3 253,7 en las personas de 65 años y más. Este patrón refuerza la importancia de mantener acciones de vigilancia y prevención dirigidas especialmente a la niñez temprana y a la población adulta joven.
En términos absolutos, el mayor número de casos se concentra en los grupos de 20 a 24 años (44 724 casos) y 25 a 29 años (44 184), seguidos por los grupos de 35 a 39 años (37 719) y 30 a 34 años (37 659).
De acuerdo con los datos consignados en el cuadro, se registran 191 107 casos en mujeres y 162 277 en hombres. Por grupo de edad, el número de casos es mayor en hombres entre los menores de 1 año, 1 a 4 años, 5 a 9 años, 10 a 14 años y 35 a 39 años. En los demás grupos etarios predominan los casos registrados en mujeres.

Recomendaciones a la población

Ante la ocurrencia de casos y brotes de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), el Ministerio de Salud recomienda reforzar las medidas de prevención relacionadas con la higiene, el consumo de agua segura y la manipulación adecuada de los alimentos.
Se recomienda acudir oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal, signos de deshidratación o sangre en las

heces, especialmente cuando varias personas presentan síntomas similares después de consumir los mismos alimentos o agua.
Asimismo, se insta a la población a informar al Ministerio de Salud sobre situaciones que puedan representar un riesgo sanitario, como enfermedad de varias personas asociada a un mismo establecimiento o alimento, deficiencias de higiene, problemas de refrigeración, alimentos en mal estado o prácticas inadecuadas de manipulación. La notificación temprana facilita la investigación de brotes y la aplicación oportuna de medidas de control.

Para prevenir la EDA:
Mantener un adecuado lavado de manos.
Consumir agua segura.
Cocinar adecuadamente los alimentos.
Mantener una correcta refrigeración y conservación.
Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y preparados.
No consumir alimentos en mal estado o de procedencia dudosa.

Conclusión EDA

A la SE 39 de 2026, la EDA continúa representando una carga relevante para la salud pública en Costa Rica, con 353641 casos acumulados y una tasa nacional estimada de 6 678,2 casos por 100 000 habitantes. Aunque desde la SE 33 se observa una disminución progresiva en los casos notificados, esta tendencia debe interpretarse con cautela debido al rezago habitual en la consolidación de los registros y a que la SE 39 se mantiene ligeramente por encima del umbral de alerta del canal endémico.

El seguimiento epidemiológico debe orientarse a confirmar la evolución de la tendencia y vigilar particularmente los territorios con mayor incidencia. El Pacífico Central y la Región Central Sur presentan las tasas regionales más elevadas, mientras que a nivel cantonal destacan Orotina, Vázquez de Coronado, Flores, Montes de Oro, Esparza, Mora y Puntarenas con tasas superiores a 10 000 casos por 100 000 habitantes.

Resulta fundamental reforzar las medidas de prevención, especialmente el lavado adecuado de manos, el consumo de agua segura, la correcta cocción y conservación de los alimentos y la prevención de la contaminación cruzada.

En este contexto, la aplicación oportuna del Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), junto con la vigilancia activa, la investigación de campo y la respuesta temprana ante alertas locales, constituye un elemento clave para identificar fuentes de transmisión, implementar medidas de control y reducir el impacto de la enfermedad en las poblaciones y territorios más afectados.

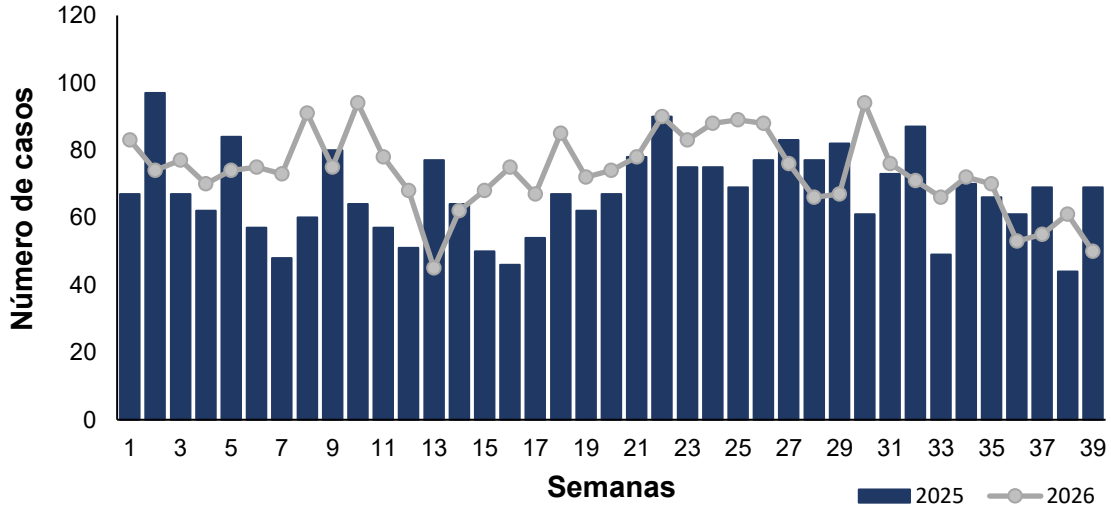
Infecciones de transmisión sexual

La notificación de las infecciones de transmisión sexual (ITS) es de carácter obligatorio, según lo establecido en el Decreto N.º 40556-S. En este marco, la vigilancia epidemiológica semanal de las ITS constituye una herramienta fundamental para el monitoreo de tendencias, la detección temprana de variaciones en la incidencia y la activación oportuna de medidas de control. En cumplimiento de este mandato, se presenta el informe correspondiente al comportamiento de la sífilis en todas sus formas, gonorrea, la infección por el virus del herpes simple durante las primeras treinta y nueve semanas del año 2026.

Sífilis en todas sus formas

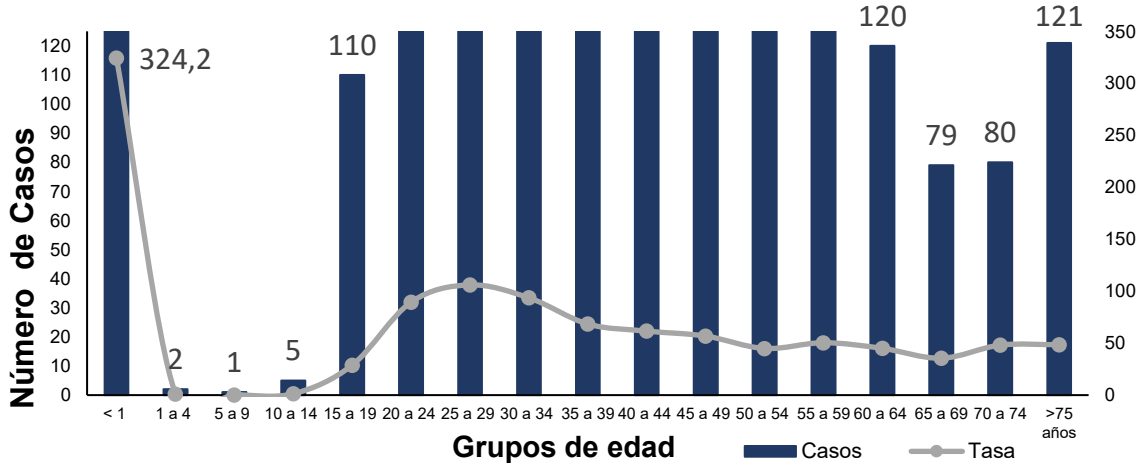
A la semana epidemiológica 39 de 2026, Costa Rica registra 2.878 casos de sífilis en todas sus formas, en comparación con los 2.410 casos notificados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 468 casos, equivalente a un 19,42 %. Aunque se mantiene un aumento en la notificación respecto al año anterior, la variación porcentual es menor que la observada en la SE 34, cuando el incremento fue del 26,01 %. Este comportamiento refleja un crecimiento acumulado de los casos notificados, cuya interpretación debe considerar tanto la posible transmisión de la enfermedad como las variaciones en la detección, el diagnóstico y la notificación. En el Gráfico 1 se presenta la distribución semanal de los casos notificados, permitiendo visualizar el comportamiento del evento durante el período analizado.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos notificados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2025 y 2026



Nota: Datos preliminares sujetes a ser actualizados semanalmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

Gráfico 2.
Costa Rica: Notificación de casos de sífilis en todas sus formas por grupos de edad, en semanas epidemiológicas 1 a 39 del 2026, según tasa por 100 000 habitantes.



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

La distribución de los casos de sífilis en todas sus formas muestra una mayor afectación en la población adulta joven, principalmente entre los 20 y 34 años. El grupo de 25 a 29 años presenta la tasa más alta, con 106 casos por 100.000 habitantes y 437 casos notificados, seguido del grupo de 30 a 34 años, con una tasa de 93,6 y 404 casos, y el de 20 a 24 años, con una tasa de 89,5 y 339 casos. A partir de los 35 años, las tasas disminuyen progresivamente, aunque se mantiene la notificación de casos en todos los grupos de edad, incluso en personas de 75 años y más.

Destaca la tasa registrada en menores de un año, de 324,2 por 100.000 habitantes, que requiere una revisión individual de los casos para determinar su clasificación final, particularmente ante la posibilidad de sífilis congénita. Estos datos deben interpretarse considerando que la información de este grupo puede modificarse conforme avanzan las investigaciones epidemiológicas. En conjunto, los resultados refuerzan la importancia de orientar las acciones de prevención, detección y tratamiento hacia la población joven y adulta, así como de fortalecer el tamizaje durante el embarazo, el seguimiento de las gestantes y la atención oportuna para prevenir la transmisión maternoinfantil.

Tabla 1.
Costa Rica: Notificación de casos de sífilis en todas sus formas, según provincias de procedencia, durante las semanas 1 a 39 del 2026. Tasa por 100 000 habitantes

Provincia	Casos	Tasa
Total	**2878**	**55.2**
San José	1172	70.3
Alajuela	359	33.2
Cartago	331	62.0
Heredia	247	44.9
Guanacaste	100	24.0
Puntarenas	194	38.1
Limón	475	103.7

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión y actualización semanal.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

El análisis por provincia evidencia diferencias importantes entre las provincias. Limón presenta la tasa más alta del país, con 103,7 casos por 100.000 habitantes, seguida de San José, con 70,3, y Cartago, con 62,0; las tres superan la tasa nacional. San José concentra el mayor número de casos notificados, con 1.172, mientras que Limón registra 475 casos y presenta la mayor afectación proporcional en relación con su población. Por su parte, Heredia (44,9), Puntarenas (38,1), Alajuela (33,2) y Guanacaste (24,0) mantienen tasas inferiores al promedio nacional. Estos resultados muestran una mayor carga de la enfermedad en Limón, San José y Cartago, por lo que es mantener las acciones de detección, tratamiento oportuno, y prevención de la transmisión maternoinfantil.

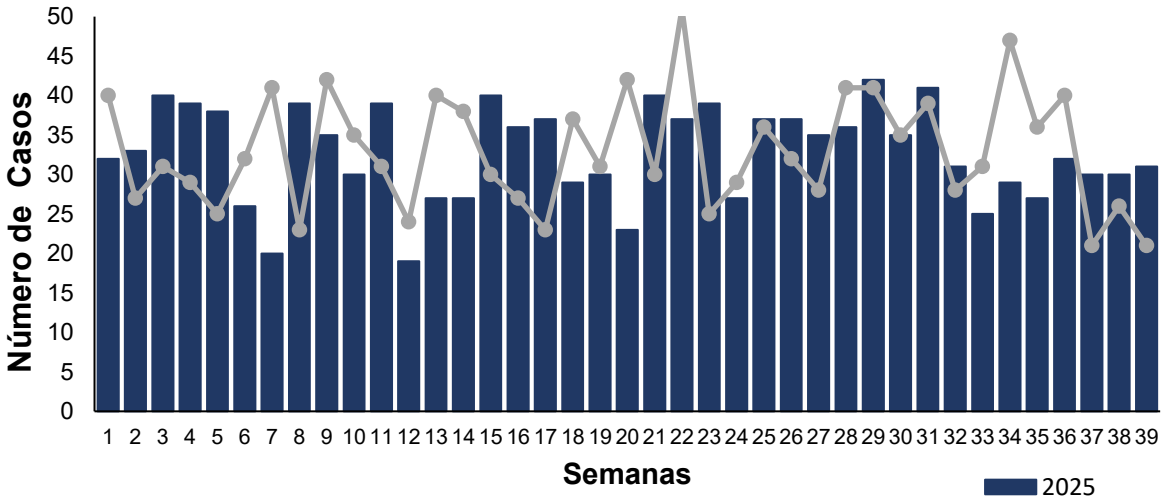
Infección por Gonorrea

Costa Rica registra 1.285 casos de gonorrea, en comparación con los 1.158 casos notificados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 127 casos, equivalente al 10,97 %. Aunque la notificación continúa por encima de la registrada el año anterior, el aumento porcentual es menor que el observado en la semana epidemiológica 34, cuando alcanzó el 15,01 %. Este comportamiento evidencia un incremento acumulado de los casos notificados, cuya interpretación debe considerar tanto la posible transmisión de la infección como las variaciones en la detección, el diagnóstico y la notificación.

Ante esta situación, es importante mantener la vigilancia epidemiológica y continuar con las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, así como el manejo de las parejas sexuales para reducir la transmisión y el riesgo de reinfección.

Gráfico 3

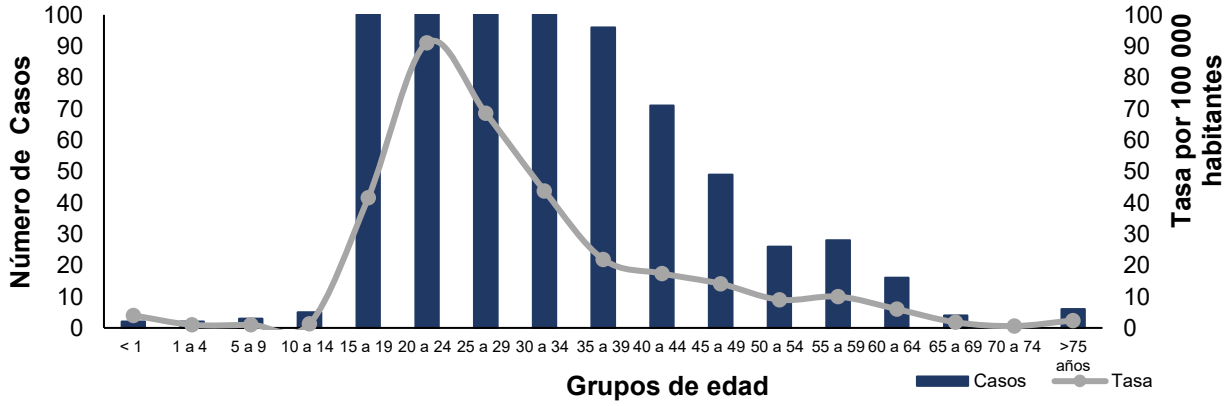
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2025 y 2026



Nota: Datos preliminares sujeto a ser actualizado semanalmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 202

Gráfico 4

Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad número absoluto, y tasa por 100 000 habitantes, durante las primeras 39 semanas del año 2026



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados semanalmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

A la semana epidemiológica 39 de 2026, la distribución de los casos de gonorrea muestra una mayor afectación en adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en el grupo de 20 a 24 años, que registra 345 casos y la tasa más alta, de 91,1 por 100.000 habitantes. Le siguen las personas de 25 a 29 años, con 283 casos y una tasa de 68,6, y el grupo de 15 a 19 años, con 159 casos y una tasa de 41,6. En conjunto, estos resultados evidencian una concentración de la enfermedad en población de 15 a 34 años, que acumula 976 casos, aproximadamente el 76 % de los casos registrados en los grupos de edad analizados. A partir de los 35 años se observa una disminución progresiva de las tasas, aunque continúan notificándose casos en personas de 60 años y más.

Por otra parte, los casos registrados en menores de 15 años, aunque pocos en número, requieren una valoración y estudio individual desde el punto de vista clínico y epidemiológico, así como la aplicación de los protocolos de protección correspondientes. Esta distribución refuerza la importancia de las estrategias de prevención, educación sexual, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, con especial atención a adolescentes y adultos jóvenes, sin descuidar el manejo de las parejas sexuales para prevenir nuevas transmisiones y reinfecciones.

Tabla 2.
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia. Número absoluto y tasa por 100 000 habitantes, en las primeras 39 semanas año 2026

Provincia	Casos	Tasa
Total	**1285**	**24,6**
San José	553	33,2
Alajuela	138	12,7
Cartago	129	24,2
Heredia	118	21,4
Guanacaste	34	8,2
Puntarenas	141	27,7
Limón	172	37,6

Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizado semanalmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

La distribución por provincia muestra que Limón presenta la tasa más alta, con 37,6 casos por 100.000 habitantes, seguida de San José, con 33,2, y Puntarenas, con 27,7; las tres provincias superan el promedio nacional. San José concentra el mayor número de casos notificados, con 553, mientras que Limón registra 172 y presenta la mayor afectación proporcional en relación con su población. Cartago presenta una tasa cercana a la nacional (24,2), mientras que Heredia (21,4), Alajuela (12,7) y Guanacaste (8,2) se mantienen por debajo. Estos resultados permiten identificar una mayor carga de gonorrea en Limón, San José y Puntarenas.

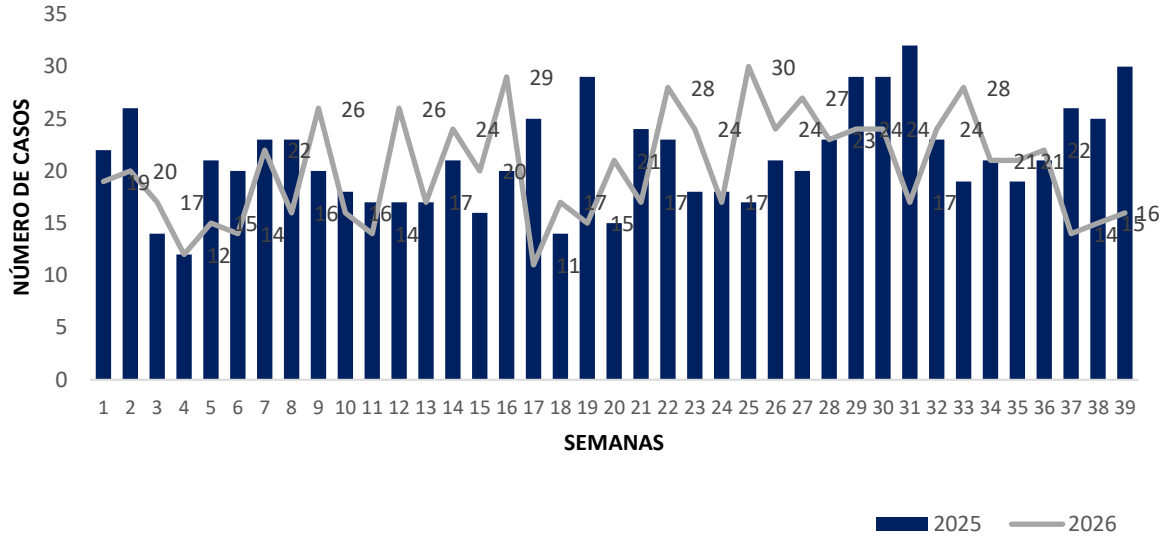
La distribución de los casos de gonorrea por sexo muestra una marcada diferencia entre hombres y mujeres. De los 1.285 casos notificados, 1.126 corresponden a hombres, con una tasa de 43,2 por 100.000 habitantes, mientras que 159 casos corresponden a mujeres, con una tasa de 6,1 por 100.000 habitantes.

Los hombres representan aproximadamente el 87,6 % de los casos notificados y presentan una tasa alrededor de 7 veces superior a la de las mujeres. Este comportamiento evidencia una mayor carga de gonorrea en la población masculina; sin embargo, es importante considerar que las diferencias también pueden estar influidas por los patrones de consulta y la detección de infecciones asintomáticas. Por ello, se recomienda mantener la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno, así como el manejo de las parejas sexuales, con especial atención a los hombres, sin descuidar la detección en mujeres para reducir el riesgo de complicaciones y nuevas transmisiones.

Infección por el virus del herpes simple (VHS)

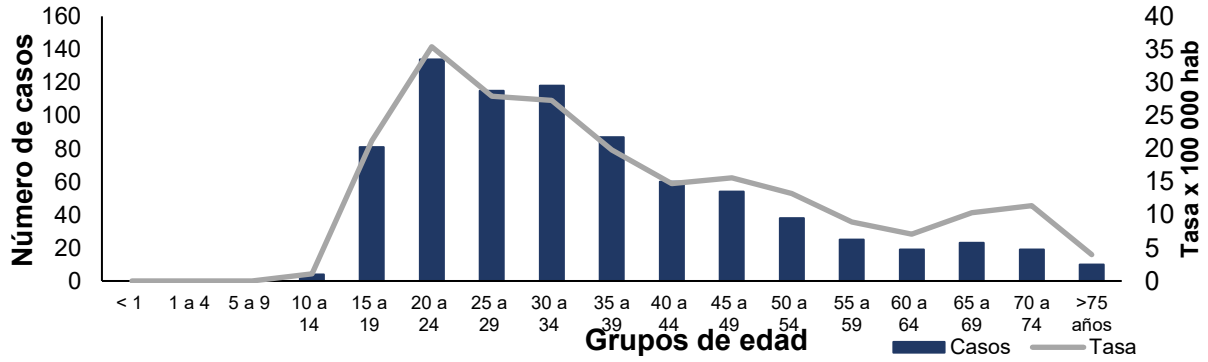
Para la semana epidemiológica 39 de 2026, se registran 787 casos notificados de herpes simple, en comparación con los 737 casos del mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 50 casos, equivalente al 6,78 %. Aunque el aumento es menor que el observado para sífilis y gonorrea, la tendencia continúa siendo ascendente y requiere mantener el seguimiento epidemiológico de esta infección. En el Gráfico 5 se presentan los datos distribuidos, según el reporte semanal.

Gráfico 5.
Costa Rica: Casos notificados por el Virus del herpes simple, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, durante los años 2025 y 2026



Nota: Datos preliminares sujetes a ser actualizados semanal.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

Gráfico 6.
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes simple, por grupos de edad en las semanas 1 a 39 del 2026. Tasa por 100 000 habitantes.



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizado semanlmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

La distribución de los casos notificados de herpes simple muestra una mayor afectación en adolescentes y adultos jóvenes. El grupo de 20 a 24 años presenta la tasa más alta, con 35,4 casos por 100.000 habitantes y 134 casos notificados, seguido de los grupos de 25 a 29 años, con una tasa de 27,9 y 115 casos, y de 30 a 34 años, con una tasa de 27,3 y 118 casos. También destaca el grupo de 15 a 19 años, que registra 81 casos y una tasa de 21,2 por 100.000 habitantes. A partir de los 35 años, las tasas tienden a disminuir, aunque se mantienen casos en los distintos grupos de edad, incluidas las personas adultas mayores. En menores de 10 años no se registran casos, mientras que en el grupo de 10 a 14 años se notificaron cuatro.

Esta distribución evidencia una mayor carga de la infección en población joven, por lo que es importante la educación sobre las formas de transmisión, las medidas de prevención, el reconocimiento de lesiones y la consulta oportuna.

En la tabla 3, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Tabla 3
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes simples, según provincias de procedencia, durante las primeras 39 semanas del año 2026. Tasa por 100 000 habitantes.

Provincias	Casos	Tasa
Total	**787**	**15,1**
San José	357	21,4
Alajuela	116	10,7
Cartago	60	11,2
Heredia	79	14,3
Guanacaste	11	2,6
Puntarenas	91	17,9
Limón	73	15,9

Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizado semanlmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

La distribución por provincia muestra que San José presenta la tasa más alta, con 21,4 casos por 100.000 habitantes, y concentra el mayor número de casos, con 357. Le siguen Puntarenas, con una tasa de 17,9, y Limón, con 15,9, ambas por encima de la tasa nacional. Heredia registra una tasa de 14,3, mientras que Cartago (11,2), Alajuela (10,7) y Guanacaste (2,6) se mantienen por debajo del promedio nacional. Estos resultados evidencian una mayor carga de casos notificados en San José y una afectación proporcional importante en Puntarenas y Limón.

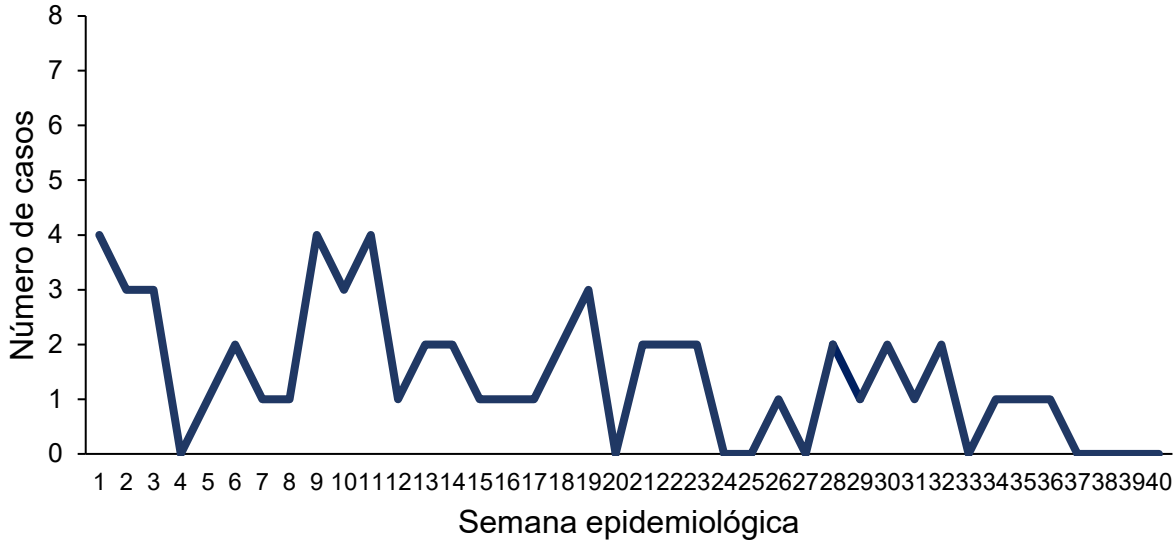
Miasis por gusano barrenador en humanos

A continuación, se presentan los datos preliminares de miasis por gusano barrenador en humanos correspondientes a la semana epidemiológica (SE) 39 del año 2026. De conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 40556-S Reglamento de Vigilancia de la Salud y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos, este evento es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

Con respecto a la notificación de casos mediante la boleta VE-01, para el período comprendido entre la SE 1 a la SE 39 del año 2026, se dispone de la siguiente información:

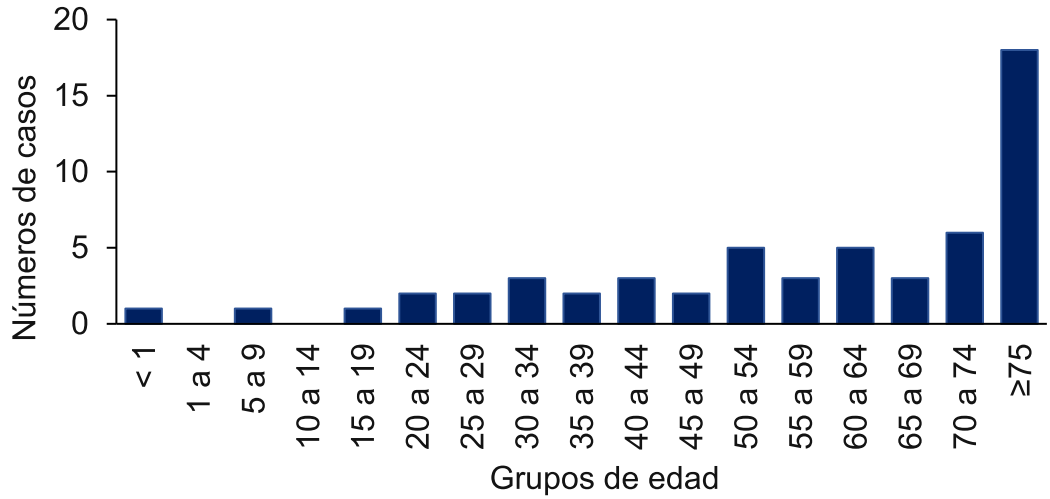
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 57 casos
- Casos por grupos de edad tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (27/57) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (27/57)

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 39, 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 39, 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En 2026, hasta la SE 39, la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos evidenció un predominio del sexo masculino, que concentró el 68,42% (39/57) de los casos notificados, con una tasa de incidencia de 1,5 casos por 100 000 habitantes. Por su parte, el sexo femenino representó el 31,58% (18/57) de los casos, con una tasa de incidencia de 0,7 casos por 100 000 habitantes.

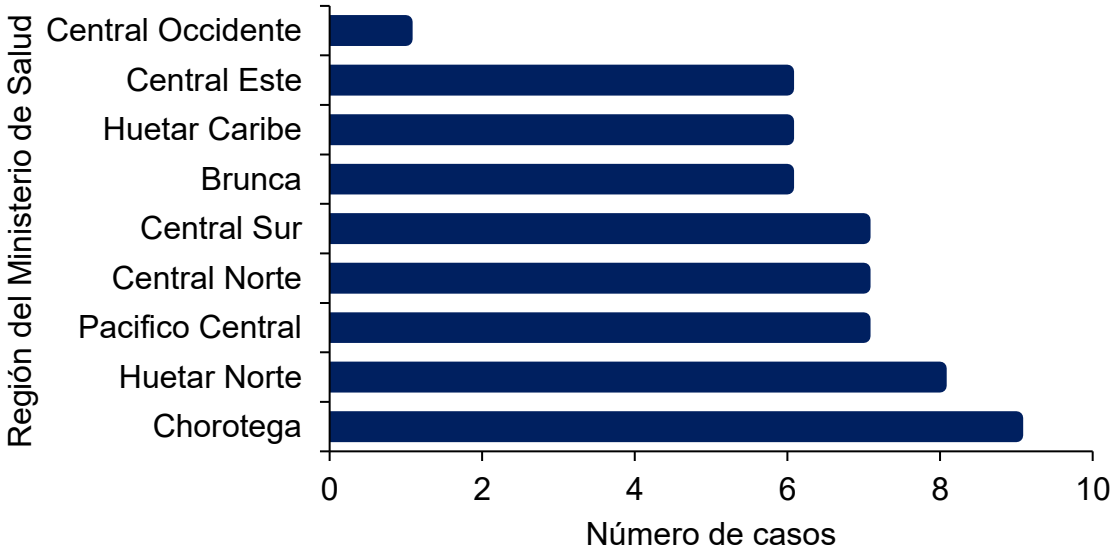
Tabla 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 39, 2026

Provincias	Casos	Tasas
Total	**57**	**1,1**
San José	10	0,6
Alajuela	12	1,1
Cartago	4	0,7
Heredia	5	0,9
Guanacaste	9	2,2
Puntarenas	11	2,2
Limón	6	1,3

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos notificados hasta la SE 39, según provincia de procedencia. La provincia de Alajuela concentra el mayor número de casos, con un total de 12 casos.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 39, 2026

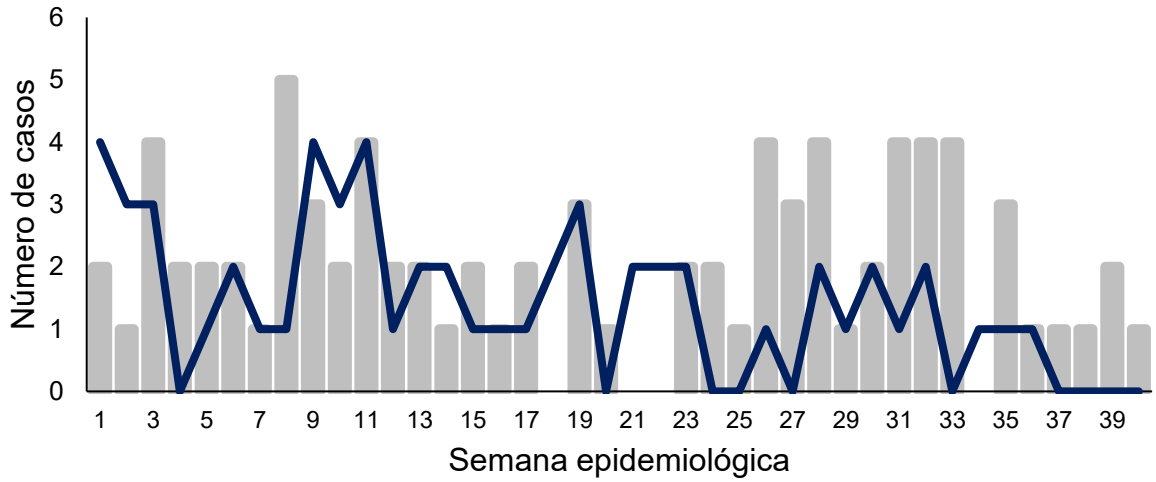


Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En el Gráfico 3 se presenta la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos notificados hasta la SE 39 en las nueve regiones rectoras del Ministerio de Salud. La Región Chorotega concentró el mayor número de casos, con 9 de los 57 casos registrados durante el período analizado.

Por su parte, el Gráfico 4 muestra el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos entre las SE 1 a la 39 de los años 2025 y 2026. Durante el año 2026 se notificaron 57 casos confirmados, mientras que para el mismo período de 2025 se habían confirmado 81 casos. Lo anterior representa una disminución de 24 casos (29,63%) en comparación con el año anterior.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 39 del 2025 y del 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025 y 2026

En atención a la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación del Gusano Barrenador (*Cochliomyia hominivorax*), establecida mediante el Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG, y considerando que la mosca continúa circulando en el territorio nacional, resulta de suma importancia que, ante la detección de un caso sospechoso en humanos, se active de manera inmediata la coordinación interinstitucional e intersectorial bajo el enfoque de **Una Sola Salud**.

Dicha coordinación involucra la participación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), según corresponda. El propósito es identificar oportunamente casos sospechosos en humanos y/o animales y garantizar su atención conforme a lo establecido en el **Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos**.

A continuación, se presentan las disposiciones generales para la prevención y control de la enfermedad:

- Acudir oportunamente a los servicios de salud públicos o privados ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad, tales como dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión.
- Mantener una adecuada higiene personal, incluyendo el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Realizar el control, tratamiento y cuidado higiénico de las lesiones conforme a las indicaciones del médico tratante.
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, efectuando revisiones periódicas y la curación de todas las heridas. Asimismo, se deberá notificar a las autoridades de salud animal (MAG-SENASA y/o MINAE) la aparición de animales con gusaneras, a fin de garantizar su atención oportuna.